

成都中医药大学

(临床医学院)

二〇二一届硕士研究生学位论文

以成都地区为例

原发性高脂血症患者中医体质类型与证候特征研究

Take Chengdu as an example

Study on constitution types and syndromes of
traditional Chinese medicine in patients with primary
hyperlipidemia

研究生姓名：贾芮婷

指导教师：冷建春 教授

学科专业：中医内科学

二〇二一年五月

学 位 论 文

以成都地区为例

原发性高脂血症患者中医体质类型与证候特征研究

Take Chengdu as an example

Study on constitution types and syndromes of traditional
Chinese medicine in patients with primary hyperlipidemia

贾芮婷

指导教师姓名：冷建春 教授

申请学位级别：硕士研究生 专 业 名 称：中医内科学

论文提交时间：2021 年 6 月 论文答辩时间：2021 年 5 月

二〇二一年五月

中文摘要

目的：本研究通过分析原发性高脂血症患者临床客观数据资料与体质类型、中医证候之间的联系，探索其间的相关性，用以指导临床预防及治疗。

方法：1. 通过现场调查问卷的方式，收集住院病人中原发性高脂血症患者的一般情况临床资料，判定证型分型、体质分类。2. 数据分析：应用 SPSS 25.0 软件处理数据，运用构成比、均值±标准差、多元多因素逻辑回归等进行数据分析。

结果：

1. 纳入分析的 328 例患者中，男性 181 例（55.2%），女性 147 例（44.8%），男性多于女性。年龄分组中中年组 213 例（64.9%）人数最多。BMI 分组中正常组 134 例（40.9%），过重组及以上共 191 例（58.2%）。血脂指标中：男性的 TG 均值明显高于女性；TG、HDL-C 在各个 BMI 分组中，具有明显差异：过重组、肥胖组 TG 均值高于正常组，而 HDL-C 均值低于正常组。中医证型在一般临床资料中的分布有差异，其中女性气滞血瘀证较男性多，青年组、中年组痰湿阻遏证多见。体重超重易形成痰湿阻遏证。

2. 研究对象中医体质分型在年龄、性别、BMI、血脂指标分布中各有差异：青年组中湿热质数量最多；中年组中痰湿质、湿热质占比最多；老年组中痰湿质最多见。BMI 分组中，痰湿质、湿热质是偏重组及肥胖组中数量最多的前两位。

结论：

1. 原发性高脂血症中，患者年龄主要集中在 41-65 岁，男性数量多于女性，患者体重大多数超过正常体重上限。在原发性高脂血症的血脂指标中，患者的体重指数与 HDL-C 呈负相关。

2. 原发性高脂血症患者中医证型分布有差异，其中女性气滞血瘀证较男性多，青年、中年患者痰湿阻遏证多见。痰湿阻遏证的患者更容易体重过重及肥胖。

3. 原发性高脂血症患者中气虚质、阳虚质多为女性患者，与阳虚质相比，气虚质与女性的相关性更高。BMI 与阴虚质、湿热质、痰湿质高度相关；阴虚质与 BMI 呈负相关，湿热质、痰湿质与 BMI 呈正相关。痰湿质、湿热质患者的 BMI、TG 数值较其他体质患者更高。

关键词：原发性高脂血症；中医体质类型；中医证候

Abstract

Purpose:Objective: By analyzing the correlation between clinical objective data of clinical patients and constitution types and TCM syndromes, this study explores the correlation between them,in order to guide clinical prevention and treatment.

Method:1. The general information, such as sex and age, syndrome type and blood lipids, of the inpatients with primary hyperlipidemia were collected by means of field questionnaire. According to "TCM Clinical Diagnosis and Treatment Terminology Syndrome Part", the patients were divided into TCM syndrome type. The constitutions of patients were classified according to the 9 constitutions standards in Classification and Determination of Constitutions of Traditional Chinese Medicine. 2. Data analysis: SPSS 25.0 software was used to process the data, and the data were analyzed by component ratio, mean $\pm$ standard deviation, multivariate logistic regression and so on.

RESULT:

1. Of the 328 patients included in the analysis, there were 181 males (55.2%) and 147 females (44.8%), with more males than females. There were 213 cases (64.9%) in the middle-aged group and the middle age group had the largest number of patients. In the different BMI group, The normal group has 134 cases (40.9%), and 191 cases (58.2%) were overrecombinant or above. Among the lipid indexes, The mean value of TG in male was significantly higher than that of female. TG and HDL-C were significantly different in all BMI groups: The mean value of TG in obese group was higher than that in normal group, while the mean value of HDL-C was lower than that in normal group.The distribution of TCM syndrome types in general clinical data is different,in which the syndrome of Qi stagnation and blood stasis in females is more than that in males,and the syndrome of phlegm-dampness repression is more common in young and middle-aged patients. Overweight and obese patients are prone to phlegm and dampness repression.

2. The types of TCM constitutions of the study subjects varied in age, sex, BMI,

and the distribution of blood lipid indexes. The amount of humidity and heat mass was the highest in the young group; The proportion of phlegm and dampness and heat in middle age group was the highest. Phlegm moisture was most common in the elderly group. In BMI Group, phlegm-dampness and damp-heat were the most in overweight group and obesity group.

Conclusion:

1. In primary hyperlipidemia, the patients are mainly aged 41-65 years old, the number of men is more than women, and the weight of most patients exceeds the upper limit of normal weight. Among the blood lipid indicators of primary hyperlipidemia, the higher the patient's body mass index, the higher the value of triglycerides and high-density lipoprotein cholesterol.

2. There are differences in the distribution of TCM syndromes in patients with primary hyperlipidemia, among the syndrome of qi stagnation and blood stasis is more common in women than in men, and the syndrome of phlegm dampness repression is more common in young and middle-aged patients. Patients with phlegm suppression are more likely to be overweight and obese.

3. In patients with primary hyperlipidemia, the quality of qi deficiency and yang deficiency are mostly female patients; the phlegm-dampness quality, damp-heat quality, and yin-deficiency quality are all related to BMI, and the BMI and TG values of patients with phlegm-dampness quality and damp-heat quality are relatively high. Other physique patients are higher.

Key Words: primary hyperlipidemia; Constitution type of traditional Chinese medicine; The doctor of traditional Chinese medicine syndrome

中英文对照表

英文缩写	英文全称	中文全称
BMI	Body Mass Index	身体质量指数
HDL-C	high-density Lipoprotein	高密度脂蛋白胆固醇
LDL-C	Low-density Lipoprotein	低密度脂蛋白胆固醇
TC	total cholesterol	总胆固醇
TG	triglyceride	甘油三酯

目录

中文摘要.....	1
Abstract.....	2
中英文对照表.....	4
前言.....	8
第一部分 临床研究.....	9
1. 研究对象.....	9
1.1 病例来源.....	9
1.2 诊断标准.....	9
1.3 纳入标准.....	10
1.4 排除标准.....	10
1.5 剔除标准.....	11
2.研究方法.....	11
2.1 资料收集.....	11
2.2 数据分类定义.....	12
2.3 调查质量控制.....	12
3.统计方法.....	13
3.1 样本量的估算.....	13
3.2 数据统计.....	13
第二部分 结果与分析.....	14
1. 原发性高脂血症患者分布情况.....	14
1.1 年龄与性别分布情况.....	14
1.2 BMI 分布情况.....	15
1.3 纳入患者临床分类情况.....	17
1.4 相关因素分布情况.....	18
2.一般资料与血脂指标比较.....	18
2.1 不同性别中血脂指标比较.....	18
2.2 各年龄段的血脂指标比较.....	19
2.3 各 BMI 分组的血脂指标比较.....	19

3.研究对象的中医证型规律分布情况.....	20
3.1 研究对象中医证型总体分布情况.....	20
3.2 研究对象中医证型分布与性别的关系.....	21
3.3 研究对象中医证型分布与年龄的关系.....	21
3.4 研究对象中医证型分布与 BMI 分组的关系.....	22
4.研究对象中医体质类型分布情况.....	23
4.1 研究对象中医体质类型总体分布特点.....	23
4.2 研究对象中医体质类型的性别分布特点.....	24
4.3 研究对象中医体质类型的年龄分布特点.....	25
4.4 研究对象中医体质类型的 BMI 分布特点.....	26
4.5 研究对象体质类型与客观资料的相关性分析.....	27
第三部分 讨论与结论.....	29
一、中医对高脂血症的认识.....	29
1.病名追溯.....	29
2.中医病因研究.....	29
3.中医脏腑辨证.....	30
二、中医体质学说.....	32
1.中医体质命名及中医体质学说追溯.....	32
2.体质的影响因素与分类.....	33
三、关于本次研究结果的讨论.....	38
1.研究对象客观资料的一般特征.....	38
2.研究对象的中医证候分布情况.....	40
3.研究对象的中医体质分布情况.....	40
四、研究结论.....	42
不足与展望.....	43
致谢.....	44
参考文献.....	45
文献综述.....	49
附录.....	53

附录 1 一般情况调查表.....	53
附录 2 中医体质量表.....	54
附录 3 在读期间公开发表的学术论文、专著及科研成果.....	62

前言

2012 年我国成人血脂异常指南报告中指出，我国成人血脂异常总的患病率为 40.4%，血脂异常是动脉粥样硬化性心血管疾病的独立危险因素，尤其是当以 LDL-C 或 TC 升高为主时，TC 每降低 1%，冠心病发病率降低 2%，TC 含量每下降 10%，冠心病死亡率降低 13%~14%。^[1]，已严重影响到人们的健康及生活质量。据估计 2010 年至 2030 年这 20 年期间，我国心血管事件将会增加 920 万^[2]。近年来，我国的血脂异常的知晓率与治疗率虽较前提高^[3]，但仍处于低水平阶段，因此有效防治血脂异常的发生仍是临床工作的重点。目前临床上普遍运用西药治疗高脂血症，但长期应用降脂药副作用较大，常见胃肠道反应、口干及食欲减退、脸部潮红、恶心、呕吐肝脏损害等副作用。而传统中医中药在治疗高脂血症中有明显优势。治未病思想一直以来都是传统中医药的基础思想理论；与治未病一样，体质学说也是黄帝内经中的主要组成部分，内经认为不同体质对于疾病有不同的易感性；体质有差异，感邪后其转归预后亦各有差异。因此本次研究为明晰原发性高脂血症患者的中医证候、体质类型与临床客观指标之间的联系，探索并分析验证其间的相关性，以期指导临床防治。

第一部分 临床研究

1. 研究对象

1.1 病例来源

本研究数据来源于 2020 年 04 月至 2021 年 01 月期间于成都中医药大学附属医院住院的患者，对其进行现场调查问卷填写和一般临床资料收集。

1.2 诊断标准

1.2.1 高脂血症诊断标准

在正常饮食状态下，参照《中国成人血脂异常防治指南（2016 年修订版）》^[4]诊断标准。即：TC $\geq$ 5.20mmol/L 和（或）TG $\geq$ 1.70mmol/L 和（或）HDL-C $<$ 1.04mmol/L 和（或）LDL-C $\geq$ 3.40mmol/L。满足其中一条便可诊断。

1.2.2 原发性高脂血症诊断标准

（1）由某些疾病如：糖尿病、系统性红斑狼疮、甲减、肾综、肾衰竭等引起的血脂异常。

（2）由某些药物如：利尿药、 β 受体拮抗剂、糖皮质激素等引起的血脂异常。

排除以上原因即可诊断。

1.2.3 中医证候判断标准

参照 2002 年《中药新药临床研究指导原则》高脂血症中医分型标准，分脾肾阳虚证、肝肾阴虚证、痰浊阻遏证、阴虚阳亢证、气滞血瘀证 5 型。中医证候分型症状参照 1997 年《中医临床诊疗术语证候部分》^[5]制定以下中医证候判断

标准:

(1) 脾肾阳虚: 面色晄白, 形体肥胖, 下肢浮肿, 性欲减退, 气短乏力, 神疲懒言, 自汗, 畏寒肢冷, 夜尿频数而清, 精神疲倦, 嗜睡。具备 5 项者。

(2) 肝肾阴虚: 两目干涩或视力减退, 耳鸣耳聋, 失眠多梦五心烦热, 腰膝酸软, 健忘, 齿松发脱, 午后颧红, 潮热盗汗, 男子遗精或早泄。具备 5 项者。

(3) 痰浊阻遏: 头重头蒙, 口中臭秽, 脘腹胀满, 妇女带下量多, 身体困重, 身热不扬, 口中粘腻。具备 4 项者。

(4) 阴虚火旺: 头痛, 头晕面赤, 烦躁易怒, 口干, 五心烦热, 大便干结。具备 3 项者。

(5) 气滞血瘀: 口渴不欲多饮, 口唇、面色紫暗, 胸痛、胸闷, 胁下痞块, 胸闷胀满或刺痛, 肢体麻木。具备 3 项者。

1.2.4 中医体质判定标准

参照《中医体质分类与判定》^[6] (2009) 标准。将体质分为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质九种。

1.3 纳入标准

- ①符合原发性高脂血症诊断。
- ②虽服用过调脂药物, 但已停药 2 周以上, 现血脂水平仍然符合诊断。
- ③性别不限, 年龄范围在 18-80 岁。
- ④神志思维清楚、语言表达能力正常。
- ⑤对调查知情同意。

1.4 排除标准

- ①妊娠或哺乳期妇女。
- ②正在使用影响血脂代谢的药物。
- ③围手术期或肝肾功能障碍、造血系统疾病、恶性肿瘤、脏器衰竭等严重原

发性疾病。

④在调查期间患感冒、急性胃肠炎等急性疾病，干扰证候判别者。

1.5 剔除标准

①纳入后，发现不符合纳入标准。

②患者依从性差，未能按照要求填写的。

③采集项目不完整，缺项多于 20%者。

④中医体质、辨证分型不明确者。

2.研究方法

2.1 资料收集

2.1.1 调查表的选用

设计《原发性高脂血症临床资料信息调查表》（见附录 1）：收集患者一般资料。包括患者姓名、性别、年龄、身高、体重、BMI（身体质量指数=体重（Kg）/身高²（m²））、烟酒史、过敏史、饮食运动情况、既往病史、家族史、临床血脂指标、中医证候分型。体质量表参考《中医体质分类与判定》^[6]（2009）标准中的 9 种体质判定亚量表（见附录 2）。

2.1.2 中医体质判定方法

《中医体质分类与判定》中每个亚量表中包含 7-8 个问题，共 60 个问题，每个问题按照答案评级 1-5 分，根据患者回答，选择合适评级。研究人员将每张亚量表的各个条目数分值相加，计为单张亚量表的原始分；转化分=[(原始分-一条目数)/(条目数×4)]×100。分别计算 9 张亚量表的原始分及转化分，并判定体质类型。除平和质外，其余的 8 种体质均为偏颇体质。

体质类型	条件	判定结果
平和质	转化分 ≥ 60 分	是
	其他 8 种体质转化分均 < 30 分	
	转化分 ≥ 60 分	基本是
	其他 8 种体质转化分均 < 40 分	
偏颇体质	不满足上述条件者	否
	转化分 ≥ 40 分	是
	转化分 $30 \sim 39$ 分	倾向是
	转化分 < 30 分	否

注：（1）在平和质中把“基本是”归为“是”；（2）偏颇体质中把“倾向是”归为“是”。

2.1.3 临床血脂指标

在正常饮食情况下，所有纳入患者均为晨起空腹留静脉血标本，选择 TC、TG、HDL-C、LDL-C4 项血脂指标数据。

2.2 数据分类定义

（1）年龄：根据我国年龄分段标准，将纳入患者分为三组：青年组 18-40 岁、中年组 41-65 岁、老年组 66-80 岁。

（2）BMI：根据《中国成人超重和肥胖症预防指南》^[7]，将 BMI(kg/m²)分为：过轻 BMI <18.5 ，正常 $18.5 \leq \text{BMI} < 24.0$ ，过重 $24.0 \leq \text{BMI} < 28.0$ ，肥胖 BMI ≥ 28 。

2.3 调查质量控制

（1）整个调研过程严格执行质量控制，调查人员参加流行病学调查表统一的

培训，统一调查方法。

(2) 参与问卷调查的人员均需熟练掌握中医理论知识、四诊技能，且为中医内科学相关人员，保证问卷质量。

(3) 严格按照设定的纳入、排除标准选取研究对象。

(4) 主要研究人员应按照标准复核问卷、录入数据，严格根据相关标准进行中医证型、体质判定。

3.统计方法

3.1样本量的估算

根据《现代医学统计学》，样本量取变量数的 5-20 倍，考虑到存在无效样本的因素，最终共纳入患 328 例。

3.2数据统计

将纳入病例的一般资料、血脂指标、体质类型、中医证型等数据输入 excel 表中，应用 SPSS25.0 软件进行数据统计。计量资料用均值±标准差、中位数四分位数间距描述；计数资料用频数、百分比描述。单因素分析用单因素方差检验、非参数检验；计数资料各组之间采用卡方检验；多因素分析用多元逻辑回归分析。 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

第二部分 结果与分析

1. 原发性高脂血症患者分布情况

1.1 年龄与性别分布情况

328 例研究对象中：男性 181 例（55.2%）、女性 147 例（44.8%）。男性多于女性。在男性患者中，年龄最大为 77 岁，最小为 20 岁，平均年龄为 41.2 岁；在女性年龄患者中，年龄最大为 80 岁，最小为 28 岁，年龄为 54.8 岁。由表 1-2 看出，青年组 74 例、中年组 213 例、老年组 41 例，经卡方检验 $P=0.000<0.01$ ，328 例研究对象在年龄分布上差异具有显著的统计学意义。

表 1-1：各年龄段与性别组成分布表

年龄分组	男性		女性		合计	
	频数（构成比%）		频数（构成比%）		频数（构成比%）	
青年组	57	（17.4）	17	（5.2）	74	（22.6）
中年组	110	（33.5）	103	（31.4）	213	（64.9）
老年组	14	（4.3）	27	（8.2）	41	（12.5）
总计	181	（55.2）	147	（44.8）	328	（100.0）

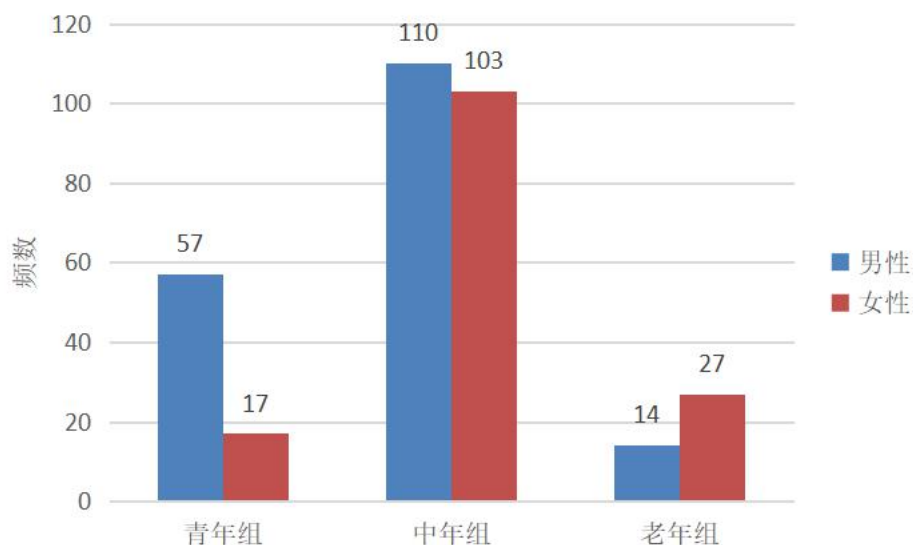


图 1：328 例患者性别与年龄分布图

1.2 BMI分布情况

1.2.1 BMI 总体分布情况

328 例研究对象中，BMI 值最小为 16.8，最大为 37.2。

表 1-2-1：BMI 总体分布情况表

BMI	过轻组	正常组	过重组	肥胖组
频数	3	134	143	48
构成比%	0.9	40.9	43.6	14.6

由表 1-2-1 看出：过重组数量最多（43.6%），其次为正常组（40.9%）。BMI 超过正常（过重组+肥胖组）人数为 191 例（58.2%）。

1.2.2 BMI 与性别分布情况

本次研究 328 例数据中，男性 BMI 平均值为 25.5，女性 BMI 平均值为 24.0。

表 1-2-2：BMI 与性别分布表

BMI	男性		女性	
	频数	构成比%	频数	构成比%
过轻组	1	0.3	2	0.6
正常组	57	17.4	77	23.5
过重组	90	27.4	53	16.2
肥胖组	33	10.1	15	4.5
总计	181	55.2	147	44.8

由表看出：男性中过重组数量最多，为 90 例（27.4%）；女性正常组数量最多，为 77 例（23.5%）。

男性中超过正常体重（过重组+肥胖组）占男性总数的 68.0%；

女性中超过正常体重（过重组+肥胖组）占女性总数的 46.3%。

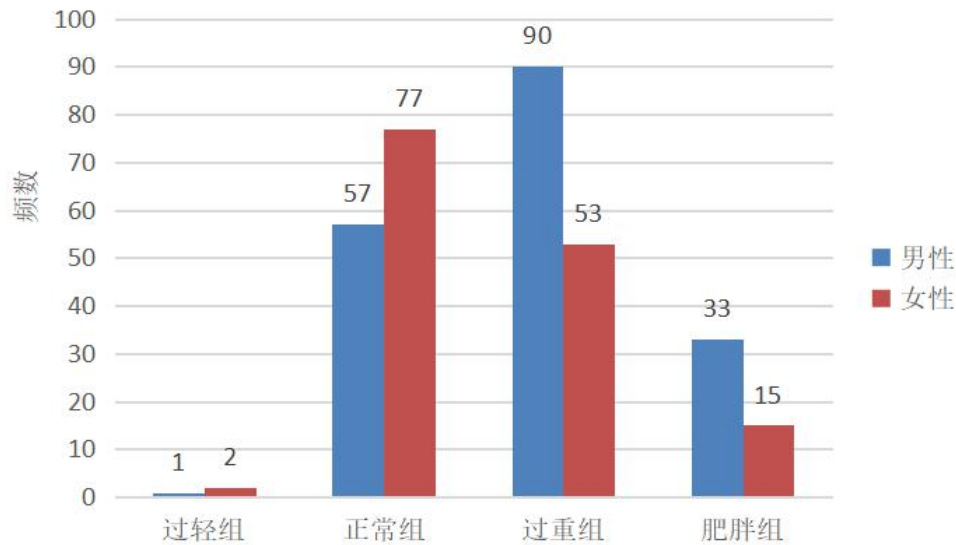


图 2: BMI 与性别分布图

1.2.3 BMI 与年龄段分布情况

表 1-2-3: BMI 与年龄分段分布表

BMI	青年组		中年组		老年组	
	频数	构成比%	频数	构成比%	频数	构成比%
过轻组	0	0.0	2	0.6	1	0.3
正常组	29	8.8	87	26.5	18	5.5
过重组	31	9.5	95	29.0	17	5.2
肥胖组	14	4.2	29	8.8	5	1.5
合计	74	22.6	213	64.9	41	12.5

由表可知：青年组、中年组中均为 BMI 过重组人数最多，分别为 31 例（9.5%）、95 例（29.0%）；老年组中 BMI 正常组人数最多，为 18 人（5.5%）。

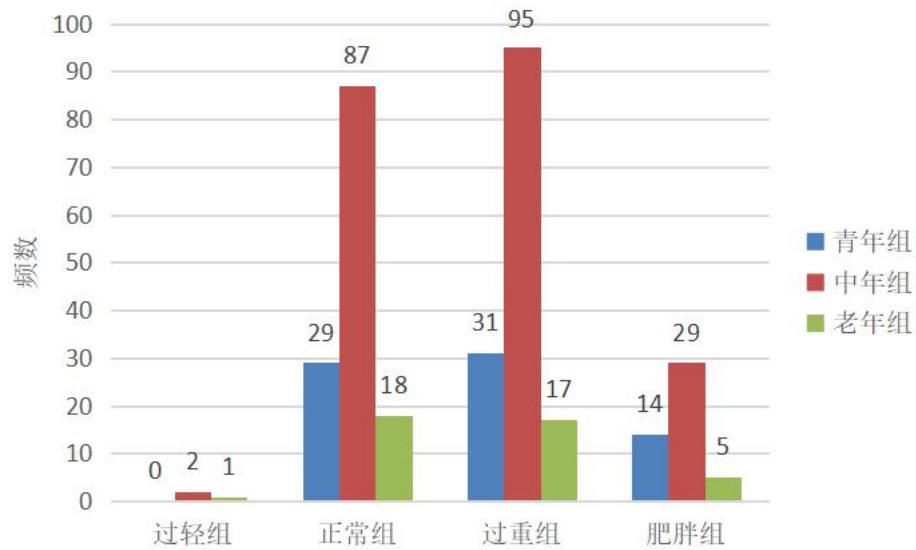


图 3: BMI 指数与年龄段分布图

1.3 纳入患者临床分类情况

表 1-3: 328 例原发性高脂血症患者临床分类情况分布表

临床分类	频数	构成比%
高胆固醇血症	53	16.1
高甘油三酯血症	156	47.6
混合型高脂血症	102	31.1
低密度脂蛋白血症	17	5.2
合计	328	100

从表 1-3 可知：最多为高甘油三酯血症患者 156 例、占总数 47.6%，其次为混合型高脂血症，占总数 31.1%。

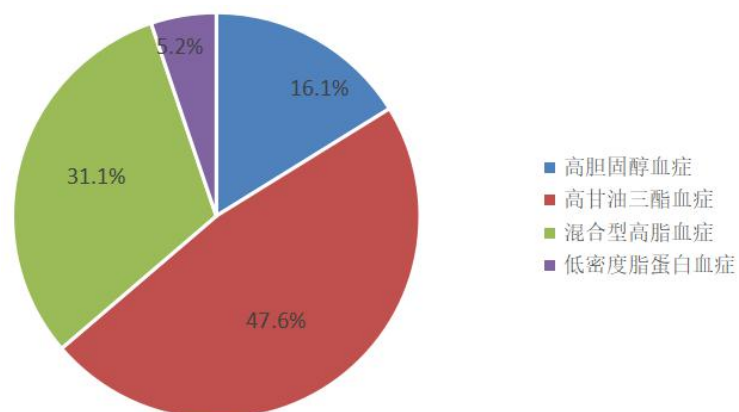


图 4：328 例原发性高脂血症患者临床分布情况图

1.4 相关因素分布情况

表 1-4：328 例原发性高脂血症患者相关因素分布表

相关因素	频数	构成比%
过重及肥胖（BMI≥24）	191	58.2
吸烟史（≥2 年）	66	20.1
饮酒史（≥2 年）	51	15.6
缺乏体育锻炼（平均<1h/周）	72	22.0
嗜食肥甘	167	50.9

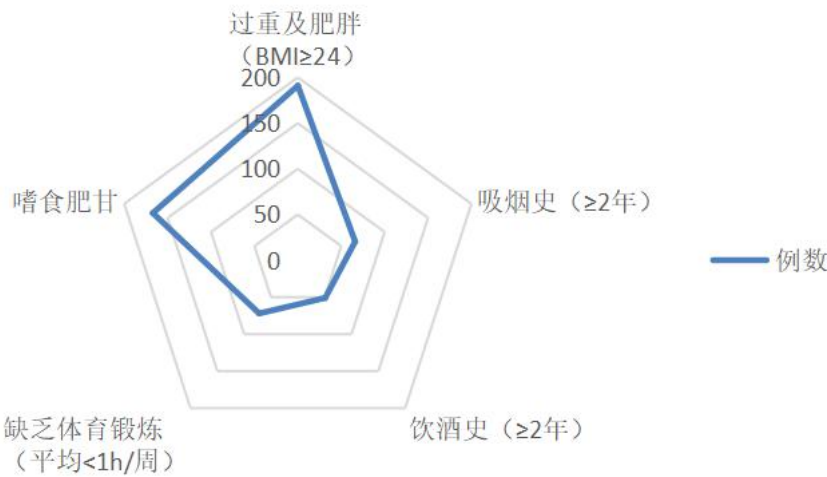


图 5：328 例原发性高脂血症患者相关因素分布图

2.一般资料与血脂指标比较

2.1不同性别中血脂指标比较

表 2-1：研究对象不同性别的血脂比较表

性别	TC	TG	HDL-L	LDL-L
	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$

男	5.18±0.92	2.91±1.57	1.17±0.34	3.13±0.77
女	5.63±0.94	1.38±1.05	1.48±0.36	3.30±0.63
T	3.381	2.822	7.166	2.573
P	0.372	0.005*	0.267	0.061

由表 2-1 看出：在 TG 项中，男性均值明显高于女性均值， $P<0.01$ ，具有明显的统计学意义。

2.2 各年龄段的血脂指标比较

表 2-2：研究对象各年龄段血脂指标比较表

年龄分组	TC	TG	HDL-C	LDL-C
	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$
青年组	5.59±0.77	2.27±1.68	1.12±0.23	3.65±0.91
中年组	5.98±0.82	2.68±1.33	1.22±0.33	3.57±0.95
老年组	6.03±0.61	2.10±1.04	1.14±0.42	3.26±0.24
P	0.036*	0.335	0.054	0.180

注：*年龄阶段血脂指标比较 $P<0.05$ 。

由表 2-2 看出：在各年龄分组血脂指标比较中，TC 值随年龄增长而递增；而具有抗动脉粥样硬化作用的 HDL-C 随着年龄的增长出现先升高后降低的趋势。

2.3 各BMI分组的血脂指标比较

表 2-3：研究对象各 BMI 分组的血脂指标比较表

BMI	TC	TG	HDL-C	LDL-C
	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$	$\bar{X} \pm s$
过轻组	—	—	—	—
正常组	5.53±0.88	1.71±1.08	1.41±0.41	3.27±0.74

过重组	5.31±1.01	2.15±1.04	1.26±0.35	3.22±0.71
肥胖组	5.39±0.81	2.39±1.32	1.22±0.23	3.24±0.56
<i>P</i>	0.619	0.025*	0.031*	0.813

注：*在 TG、HDL-C 值中，各 BMI 分组血脂指标比较 $P<0.05$ 。

由表 2-3 得出：TG、HDL-C 在不同 BMI 组中具有统计学意义。其中，BMI 过重组、肥胖组 TG 均值高于正常组，而 HDL-L 均值低于正常组。

3.研究对象的中医证型规律分布情况

3.1研究对象中医证型总体分布情况

在本次 328 例研究对象中：最多为痰湿阻遏证 114 例（34.8%），其次为气滞血瘀证 68 例（20.7%），肝肾阴虚证 63（19.2%）、脾肾阳虚证 43（13.1%）、阴虚阳亢证 40（12.2%）。

表 3-1：研究对象中医证型分布表

中医证型	频数	构成比（%）
脾肾阳虚证	43	13.1
肝肾阴虚证	63	19.2
阴虚阳亢证	40	12.2
痰湿阻遏证	114	34.8
气滞血瘀证	68	20.7
合计	328	100

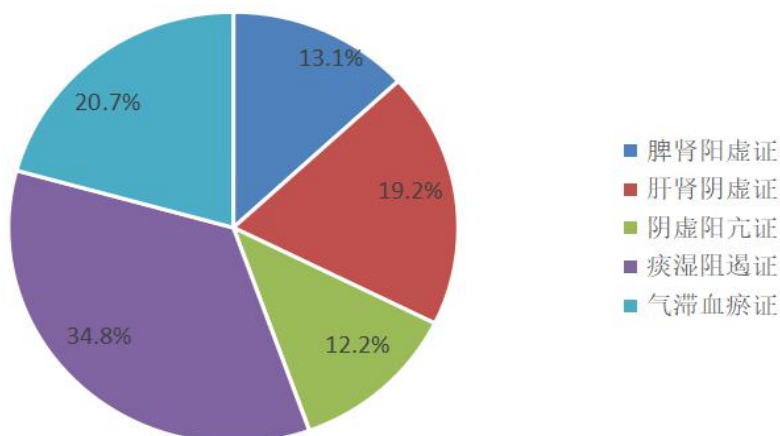


图 6: 研究对象中医证型分布图

3.2 研究对象中医证型分布与性别的关系

表 3-2: 研究对象中医证型与性别的关系表

中医证型	男性		女性	
	频数	构成比%	频数	构成比%
脾肾阳虚证	22	6.7	21	6.4
肝肾阴虚证	32	9.8	31	9.5
阴虚阳亢证	24	7.3	16	4.8
痰湿阻遏证	71	21.6	43	13.1
气滞血瘀证	32	9.8	36	11.0

由表 3-2 可见, 男性、女性中均为痰湿阻遏证最多, 分别为 71 例 (21.6%)、43 例 (13.1%)。在气滞血瘀证中, 男女数量差异有统计学意义。

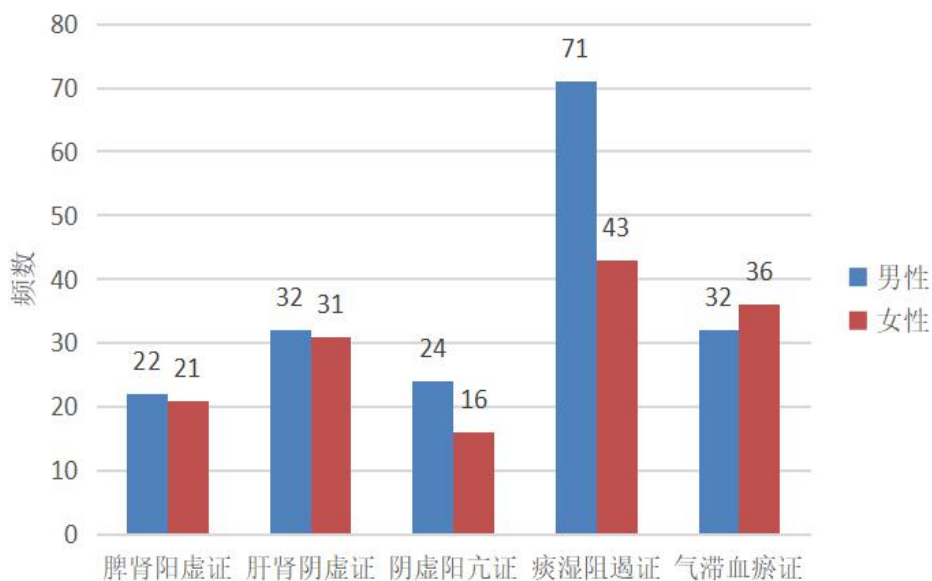


图 7: 研究对象中医证型与性别的关系分布图

3.3 研究对象中医证型分布与年龄的关系

表 3-3: 研究对象中医证型与不同年龄的关系表

中医证型	青年组		中年组		老年组	
	频数	构成比%	频数	构成比%	频数	构成比%
脾肾阳虚证	13	4.0	20	6.1	10	3.0
肝肾阴虚证	18	5.5	38	11.6	7	2.2
阴虚阳亢证	8	2.4	28	8.5	4	1.3
痰湿阻遏证	27	8.3	77	23.5	10	3.0
气滞血瘀证	8	2.4	50	15.2	10	3.0
合计	74	22.6	213	64.9	41	12.5

经卡方检验， $P<0.05$ 。表明不同年龄分组在中医证型分布上有差异。其中，中年组在痰湿阻遏证最多为 77 例（23.5%）。

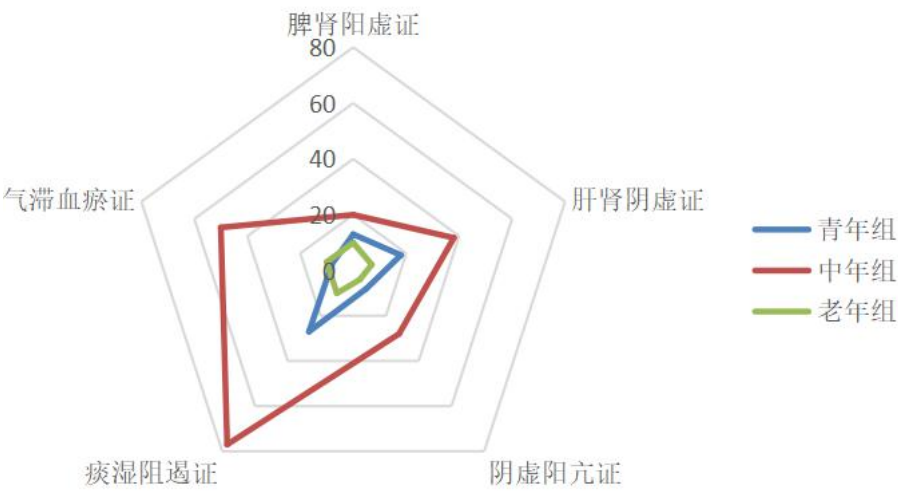


图 8：研究对象中医证型与不同年龄分组的关系图

3.4研究对象中医证型分布与BMI分组的关系

表 3-4：研究对象中医证型与 BMI 分组的关系表

中医证型	过轻组		正常组		过重组		肥胖组	
	频数	构成比	频数	构成比	频数	构成比	频数	构成比
脾肾阳虚证			13	4.0	21	6.4	9	2.7
肝肾阴虚证	2	0.6	39	11.9	16	4.9	6	1.8
阴虚阳亢证	1	0.3	26	7.9	11	3.4	2	0.6

痰湿阻遏证	32	9.6	62	18.9	20	
气滞血瘀证	24	7.3	33	10.1	11	3.4
合计	3	0.9	134	40.9	143	43.6
					48	14.6

由表 3-4 可知，BMI 正常组中肝肾阴虚证分布最多 39 例（11.9%），过重组及肥胖组中最多均为痰湿阻遏证，分别为 62 例（18.9%）、20 例（6.1%）。

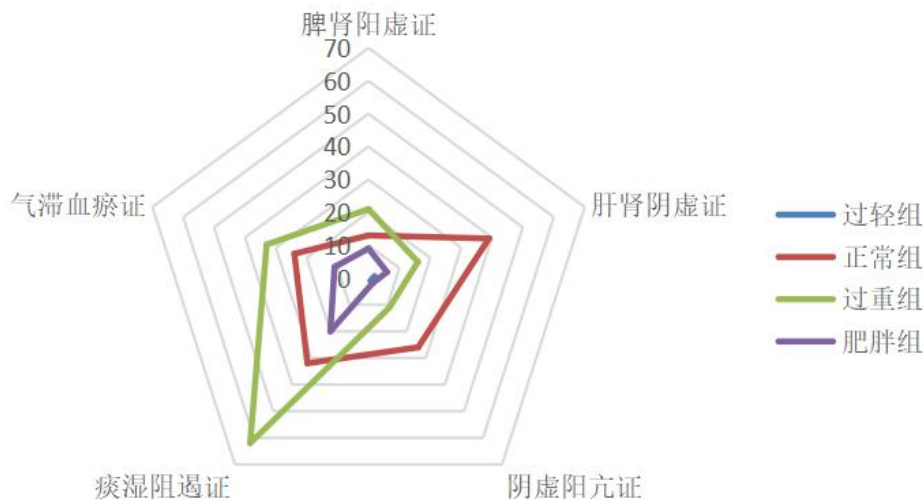


图 9：研究对象中医证型分布与 BMI 分组的关系图

4.研究对象中医体质类型分布情况

4.1研究对象中医体质类型总体分布特点

328 例研究对象中，中医体质类型分型及数量占比分别为：平和质 67 例（20.4%）、气虚质 23 例（7.0%）、阳虚质 19 例（5.8%）、阴虚质 11 例（3.4%）、湿热质 81 例（24.7%）、痰湿质 90 例（27.4%）、血瘀质 21 例（6.4%）、气郁质 13 例（4.0%）、特禀质 3 例（0.9%）。

表 4-1：研究对象体质类型分布表

体质	频数	构成比（%）
平和质	67	20.4%
气虚质	23	7.0%
阳虚质	19	5.8%
阴虚质	11	3.4%

湿热质	81	24.7%
痰湿质	90	27.4%
血瘀质	21	6.4%
气郁质	13	4.0%
特禀质	3	0.9%
合计	328	100.0%

由表可知：体质类型中数量最多前三位为：痰湿质 90 例（27.4%）、湿热质 81 例（24.7%）、平和质 67 例（20.4%）。

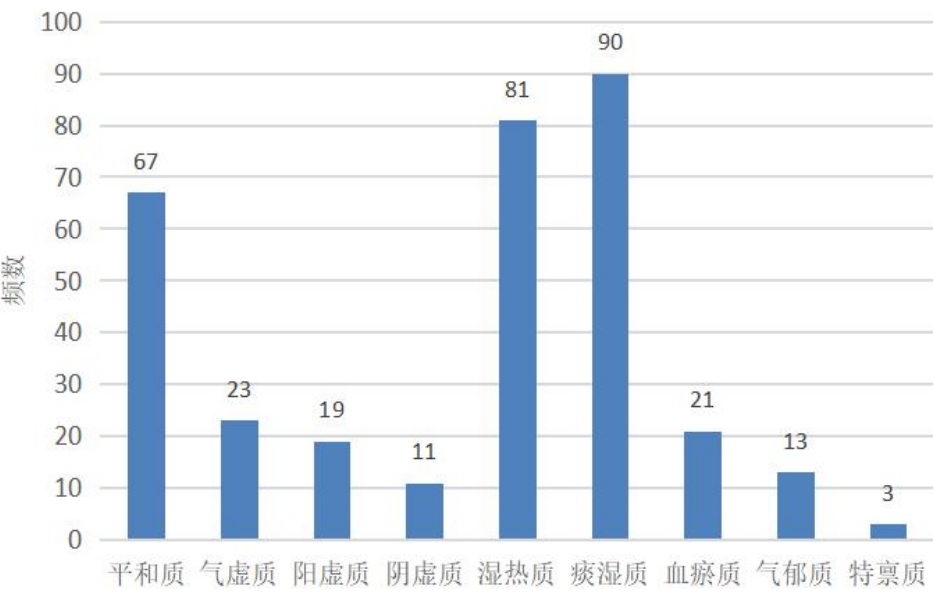


图 10：研究对象体质类型分布图

4.2研究对象中医体质类型的性别分布特点

表 4-2：328 例研究对象中医体质类型性别分布及比例

体质类型	男性		女性		P
	频数	构成比%	频数	构成比%	
平和质	37	11.3	30	9.1	0.074
气虚质	8	2.4	15	4.5	0.031*
阳虚质	6	1.8	13	4.0	0.043*

阴虚质	6	1.8	5	1.5	0.142
湿热质	49	14.9	32	9.8	0.025
痰湿质	55	16.8	35	10.6	0.011
血瘀质	13	4.0	8	2.4	0.251
气郁质	6	1.8	7	2.1	0.721
特禀质	1	0.3	2	0.6	—

注：*在性别比较中，气虚质、阳虚质 $P<0.05$ ，差异具有统计学意义。

由表可以看出：在 328 例样本数据中，男性、女性例数占比前两位均为痰湿质、湿热质。男性痰湿质 55 例（16.8%），湿热质 49 例（14.9%）；女性痰湿质 35 例（10.6%），湿热质 32 例（9.8%）。

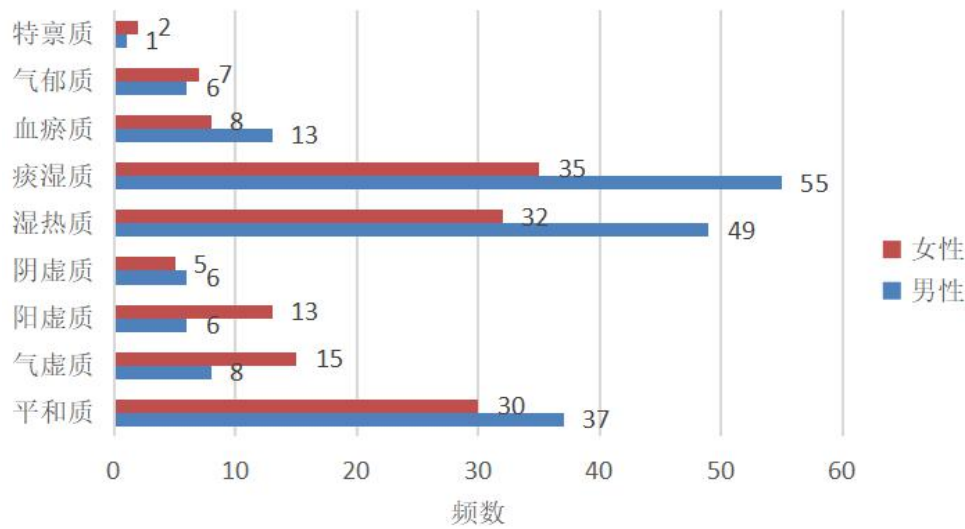


图 11：328 例研究对象中医体质类型与性别分布图

4.3研究对象中医体质类型的年龄分布特点

表 4-3：研究对象中医体质类型的年龄分布表

体质类型	青年组		中年组		老年组	
	频数	构成比%	频数	构成比%	频数	构成比%
平和质	11	3.4	45	13.7	11	3.4
气虚质	5	1.5	17	5.2	1	0.3
阳虚质	2	0.6	14	4.3	3	0.9

阴虚质	2	0.6	8	2.4	1	0.3
湿热质	21	6.4	51	15.5	9	2.7
痰湿质	20	6.1	57	17.4	13	4.0
血瘀质	9	2.7	11	3.4	1	0.3
气郁质	3	0.9	8	2.4	2	0.6
特禀质	1	0.3	2	0.6	0	0.0

注：在年龄比较中 $P<0.05$,说明年龄是影响中医体质形成的因素。

由表可知：各年龄组前三位分别是：青年组：湿热质 21 例（6.4%）、痰湿质 20 例（6.1%）、平和质 11 例（3.4%）；中年组：痰湿质 57 例（17.4%）、湿热质 51 例（15.5%）、平和质 45 例（13.7%）；老年组：痰湿质 13 例（4.0%）、平和质 11 例（3.4%）、湿热质 9 例（2.7%）。

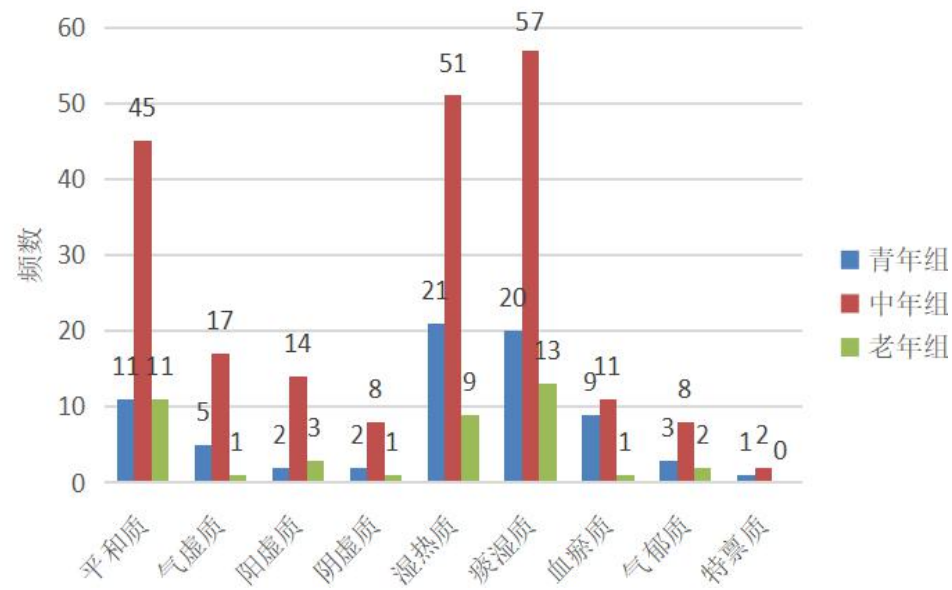


图 12：研究对象中医体质类型的年龄分布图

4.4研究对象中医体质类型的BMI分布特点

表 4-4：研究对象中医体质类型的 BMI 分布表

体质类型	过轻组		正常组		偏重组		肥胖组	
	例数	构成比%	例数	构成比%	例数	构成比%	例数	构成比%

平和质			36	11.0	26	7.9	5	1.5
气虚质			16	4.9	6	1.8	1	0.3
阳虚质			9	2.7	8	2.4	2	0.60
阴虚质	2	0.6	8	2.4	1	0.3		
湿热质			26	7.9	39	11.9	16	4.9
痰湿质			18	5.5	51	15.5	21	6.4
血瘀质			10	3.0	9	2.7	2	0.6
气郁质			9	2.7	3	0.9	1	0.3
特禀质	1	0.3	2	0.6				

由表可知：BMI 正常组中平和质占比最多为 36 例（11.0%）；偏重组中痰湿质人数最多为 51 例（15.5%），其次为湿热质 39 例（11.9%）。肥胖组在痰湿质人数最多为 21 例（6.4%），其次为湿热质 16 例（4.9%）。

4.5 研究对象体质类型与客观资料的相关性分析

为了进一步检验单因素有差异的年龄、性别、血脂 4 项等自变量分别与不同体质之间的相关性，寻求它们之间的关系，选择多元 logistic 回归选择进入模型，做多元多因素 logistic 回归。①因变量 Y 为体质类型（赋值：是=1，否=0）；②自变量 X 分别为性别、年龄段、BMI、TC、TG、HDL-C、LDL-C、饮食偏好、体育锻炼、吸烟史、饮酒史。因特禀质 3 例，病例数太少，故不纳入回归分析。其中与体质具有相关性的指标如下表：

体质类型	指标	b	SE	Wald χ^2	P	OR 值
气虚质	女性	1.181	0.128	5.832	0.024	1.198
阳虚质	女性	-1.022	0.607	5.642	0.028	1.079
阴虚质	BMI	1.105	0.151	5.768	0.021	0.716
湿热质	BMI	-0.171	0.216	6.341	0.015	1.921

	TC	-1.352	0.603	5.039	0.021	0.432
	TG	1.158	0.889	10.675	0.014	2.138
痰湿质	BMI	0.318	0.093	13.218	0.006	1.743
	TG	1.165	0.438	10.231	0.012	1.591

由上表可知：BMI 每增加 1kg/m^2 ，阴虚质的概率降低 0.716 倍（OR=0.716），湿热质的概率增加 1.921 倍（OR=1.921），痰湿质的概率增加 1.743 倍（OR=1.743）；女性与气虚质、阳虚质相关，相比阳虚质，原发性高脂血症患者中气虚质女性更多。BMI 与阴虚质、湿热质、痰湿质高度相关；阴虚质患者与 BMI 呈负相关；湿热质、痰湿质与 BMI 呈正相关。TG 与痰湿质、湿热质密切相关。

第三部分 讨论与结论

一、中医对高脂血症的认识

1. 病名追溯

传统中医学典籍中并无“血脂异常”或“高脂血症”病名。高脂血症从病机的角度出发,属于“血瘀”“痰浊”“湿浊”范畴;从病的角度出发,本症亦存于中医“心悸”“肥胖”“中风”“胸痹”等病之中。现代医学中的高脂血症可对应为中医古籍中“膏”“脂”“浊”等相关描述。《素问》篇曰:“甘肥贵人则膏粱之疾也。隔塞闭绝,上下不通,则暴忧之病也”。《灵枢·卫气失常论》:“人有肥,有膏,有肉。”其中所阐述的“膏”与“肥”之间的关系类似于现代医学研究中血脂异常与肥胖之间的相关性,有研究表明^[8]超重和肥胖人群中血脂异常的发病率较正常体重人群显著升高。《医学心悟》:“凡人嗜食肥甘,或醇酒奶酪,……故卒然昏倒无知也”,其中提到的因嗜食肥甘后痰湿内生致使猝然昏倒发生中风,而近年来相关文献及临床研究亦表明高脂血症与中风发病有相关性。《灵枢》:“五谷之津液,和合而为膏者。”灵枢认为“膏”的生成是来源于饮食所化生的水谷精微;而在现代医学中外源性脂质主要是食物经过消化吸收后进入血液;两者在膏脂来源研究上具有相似性^[9]。

2. 中医病因研究

传统中医认为疾病的病因不外乎先天不足、后天失养;血脂异常的病因主要有先天禀赋、饮食不节、过逸少劳、情志不遂,最终导致脏腑功能失常而使气血津液不得正化,痰湿、瘀血阻滞脉道而发病^[10]。

2.1 先天禀赋

《灵枢》中:“以母为基,以父为楨,乃成为人”^[11]。先天禀赋是指子代从父代禀承如形态、行为、心理、疾病等一系列特性^[12]。现代西医学研究亦表明部

分原发性高脂血症是由先天性基因缺陷导致，其发病特点是具有家族聚集性。有研究表明家族性高脂血症与 APOE^[13]等基因相关。

2.2 后天因素

饮食不节 主要指食味偏好与进食过量两方面。《素问》：“味过于甘，心气喘满”，内经中本条原文是对因饮食味道过于甘甜，以至于出现心胸喘息症状的描述。李杲《脾胃论》：“至于五味，口嗜而欲食之，必自裁制，勿使过焉，过则伤其正也”；指出饮食中酸苦甘辛咸五味应适量得当，五味过度会使机体气血受损。《医学入门》：“善食厚味者生痰”；指出过度食用肥甘厚味，易酿生痰湿、痰浊。缪希雍《本草经疏》：“饮啖过度，好食油面猪脂，浓厚胶固，以致脾气不利，壅滞为患，皆痰所为”。指出进食量过饱，或者喜好油脂肉食之物、嗜食肥脂厚味，易阻滞中焦气机，气机壅塞不畅，气血津液输布不利，易酿生痰浊。

过逸少劳 传统中医认为“动则不衰”。《吕氏春秋》：流水不腐，户枢不蝼，动也。指处于流动状态的税就不会腐坏，而门轴能够一直保持转利的状态，也是因为门轴一直处于动态之下，意思是要保持运动的、非静止的状态才能延长寿命。《素问》：“久视伤血、久卧伤气、久坐伤肉”。表明长期保持一个姿势不变化，会导致人体局部气机运行不畅，长此以往就会影响全身气血运行，气不行血、气不行津，日久会形成痰湿痰浊、瘀血等病理因素。

情志不遂 中医理论中七情与各脏腑相对应，如：心在志为喜、肝在志为怒、脾在志为思。《素问》：“余知百病生于气也，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，思则气结。”说明情志可直接影响身体气机循行，气机失调，气血津液运行不畅，痰、湿、瘀阻于脉道，疾病始生。《三因极一病证方论》：“七情，人之常性，动之则先自脏腑郁发，外形于机体”，表明情志情绪是由脏腑发出，情志得当有益于脏腑气机通调，情志内伤也可直接损伤所属脏腑，导致脏腑气机逆乱、气血失和。如情志不畅，木壅土郁，伤及肝脾，津液水湿代谢失常，津聚成痰，浊脂内生，痰浊、瘀血留于脉道，日久引发血脂异常^[14]。

3.中医脏腑辨证

3.1 脾失健运

脾胃为生化维持人体最根本的精微物质的脏腑。脾主运化的功能，指脾能够将具有将食入的水谷化生为机体能够直接利用的精微物质，并通过脾气将所化生的精微物质输送至全身内外的功能。《素问》：“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精。”这便是脾主运化功能的确切论述：即为饮食水谷入于胃，经过脾胃的腐熟作用，化生的水谷精微行于脉道，在脾主升清的作用下，上输于肺，经过肺朝百脉、化赤为血，营卫之气并行于脉道，肺主宣发肃降，通过心肺气将营血卫气输送到五脏六腑、四肢百骸，以濡养全身内外、皮毛肌肉，在脾运化水湿的作用下，将经过各个器官组织利用过的水液代谢产物传输给肾，在肾气化功能正常发挥的条件下一起维持体内津液水湿代谢排出的平衡。《素问》：“诸湿肿满，皆属于脾”。肺脾肾三脏分工协同，共同调节体内水湿代谢，使之维持在相对稳定的状态；但在三脏中，脾运化水湿是其中最关键的环节；脾脏健运得当既能使水液仅为物质送达全身内外、以濡养各个脏腑组织，又不会致使局部滞留局部过多而形成水肿等病理因素。若长期饮食无制，思虑过度伤脾，都可损伤脾气、导致脾失健运，进而影响水液代谢相对稳态，而产生水湿、痰饮，形成“痰浊”、“血瘀”、“膏浊”等病理因素。“脾主运化”的生理功能决定了高脂血症与脾的关系最为密切，因此“脾失健运”是导致血脂异常的主要病机^[15]。

3.2 肝失疏泄

肝气舒畅条达，是维持全身气机调畅的基础。肝气调畅得当是体内气血津液正常运行的重要条件。①调畅气机，维持气血运行：肝气对全身气机升降出入起着重要的疏通调节作用。《读医随笔》：“凡脏腑十二经之气化，皆必藉肝胆之气化以鼓舞之，始能调畅而不病”。《风劳癥膈四大证治》：“血随气行，周流不停”。肝脏疏泄得当、脏腑生理功能正常，肝气疏通宣畅恰得其分，全身气机也能升降出入、通调适宜，气机调畅、气帅血行，气血和调。反之，则气滞血瘀。形成血瘀等病理因素。②调节水液代谢：肝脏对水液代谢的调节作用，是通过调畅气机的功能实现的。水液代谢主要是由肺脾肾三焦协同完成，因肝能调畅全身气机，因此也能促进三焦气机的调畅。进而有益于三焦对调节在水液代谢方面的

功能。《医经溯洄集》：“水者气之子，气者水之母。气行则水行，气滞则水滞”，表明气能行水，气滞水停，若肝失疏泄，则气滞水停，形成痰饮等病理产物。痰瘀互结、互为因果，相互促进。③分泌排泄胆汁：肝脏精气有余则化为精汁、储藏于胆中，胆汁的排泄有赖于肝气推动。在现代研究中，胆汁酸是体内胆固醇的代谢产物，它可随胆汁通过胆管排入肠道，直接参与脂肪的消化吸收过程，并且可以维持血脂的相对平衡，这一代谢过程也即现代医学所说的胆固醇的肠肝循环^[16]。若肝失疏泄，胆汁排泄异常，便可影响体内血脂水平。郭姣^[17]等人通过临床数据提出肝主疏泄也是血脂异常的一大关键因素。

3.3 肾失气化

肾调节水液代谢的功能是通过肾阳气的蒸化作用实现的。肾的气化功能主要通过两方面作用来维持体内水液代谢的相对平衡：一是促进津液的输布；二是促使水液代谢后浊液排除。肾为先天之本，若肾阳虚衰，肾气温煦、推动等功能衰退，则津液停聚酿为痰。王安璐^[18]等人发现中老年高脂血症的发病率明显增加，且有规律可循，女性发病时间多在更年期后，男性发病多为中年后，这与中医肾为后天之本理论高度相仿。亦有研究表明^[19]，“下丘脑-垂体-靶腺轴”中下丘脑的垂体激素，可通过调节体内血脂内环境动态平衡的自稳功能，来影响血脂水平，当该轴功能失常时可致体内脂质代谢紊乱。

二、中医体质学说

1. 中医体质命名及中医体质学说追溯

体质一词虽在《黄帝内经》中没有明确提出，但关于体质的理论在内经有大量论述，内经中“素”与“质”的表述，近似于现在的体质。如《灵枢》：“筋骨之强弱，肌肉之坚脆，皮肤之厚薄，腠理之疏密，各不同……肠胃之厚薄坚脆亦不等”。《素问》：“此人者质壮，”。《内经》中有许多专论体质的篇章；《灵枢·阴阳二十五人》中将人分为五种，分别为木形、火形、土形、金形、水形。内经中明确提出五行人的外貌特点、骨相身形、性格偏向及发病特点。《灵枢·通

天》中根据阴阳盛衰将人分为太阴之人、少阴之人、太阳之人、阳之人、阴阳和平之人五类。因此《黄帝内经》可称为是体质思想的奠基之作。及至东汉，张仲景在《伤寒杂病论》中阐明六经病的发病、传变及治疗，揭示了体质在疾病发生发展过程中的主导作用。后世一些医籍也常将体质称为“禀质”、“资质”等。至明代，张介宾^[20]在《景岳全书》提到体质一词，“矧体质贵贱尤有不同”。此后，在清代叶香岩、吴鞠通等人的著作中也出现过“体质”一词，但都没有对体质一词作透彻的阐明。其后，随着现代西医学的流入与发展，人们将传统体质与现代医学相结合，建立单独的中医体质理论学科^[21]。其中王琦的《中医体质学说》^[22]是论述中医体质的专著，奠定了现代中医体质学说的理论与实践基础，使体质理论与临床实践能够更好的结合，更广泛地推广与发挥体质学说。体质学说至现代得到了继承发扬，众多学者将其与现代研究相结合，以探求其规律与分布情况有无差异性；如王琦对 21948 例样本研究^[23]发现，在普通人群中，平和质约占 1/3，偏颇体质约占 2/3：偏颇质中以气虚质、湿热质、阳虚质较多。

2.体质的影响因素与分类

2.1 体质的影响因素

《黄帝内经》中有很多关于体质理论的阐述，其中不仅包括物质方面的阐述，如个体形体结构和生理功能的特性；也涉及精神层面的关联，如心理、性格、精神面貌、道德品质等方面。体质是一种相对稳定的固有特征；禀受于先天，并受后天影响；在生长和发育过程中形成、并与自然、社会环境相适应；由人体形态结构、生理功能和心理因素综合而成。体质是机体内外环境多种复杂因素共同作用的结果，究其形成因素，不外先天禀赋和后天因素两大方面。

2.1.1 先天因素

先天因素即“禀赋”，先天禀赋是构成人体的第一块基石。先天禀赋包括父母先天之精的遗传、子代在母体中发育的营养状况及母体对胎儿的影响。总之先天因素涵盖了胎儿出生前所有可以影响胎儿的各种因素^[24]。可分为两方面：一方

面是来自于父母之精。《灵枢》：“愿闻人之始生，以母为基，以父为楨”，在生命形成的过程中，男主阳施，女主阴受，阴阳和合，胎孕乃成。《灵枢》：“人之生也，有刚有柔，有弱有强，有短有长，有阴有阳”。明代万全《幼科发挥·胎疾》：“胎弱者禀受于气之不足也。子于父母一体而分，所以肥瘦长短，大小妍媸。”。父母生殖之精的强弱与否及父代的体质特征，决定着子代禀赋的强弱，表现在子代体质的差异上，如体型、性格、肤色的差异，甚至鸡胸生理缺陷和哮喘等遗传性疾病。现代人类遗传学的表明，遗传是由染色体上携带的基因传给后代的，父母的身高、体重、眼型、肤色、寿命等可以通过基因遗传给下一代^[25]。另一方面，是受胎后母体对胎儿的影响。《素问》：“人生而有病癰疾者，病名为胎病，在母腹中时，其母有所大惊，故令子发为癰疾也。”表明在先秦时期，中医学已认识到胎儿期母体的饮食、疾病、精神情绪等都可能对胎儿的体质产生影响。先天因素、遗传性状为体质的发展提供了可能性，而体质强弱的实际情况，主要受饮食营养、身体锻炼等后天因素的影响。

2.1.2 后天因素

大致可分为机体内在因素和外界环境因素两方面。胎儿出生之后，先天禀赋已然成定局，但在人一生中，体质并非是一成不变的，它因后天各种因素的影响而变化。

2.1.2.1 饮食因素

脾胃二脏，相辅相成共为气血生化之源，气血是构成人体最基本的物质，水谷是人体生长发育及气血津液的物质基础，故谓脾胃为后天之根本。饮食营养是决定体质强弱的重要因素。合理的谷疏搭配、营养均衡、口味调匀及科学的饮食习惯，对维护和增强体质有很大裨益^[26]。但由于各人体质相差万里，机体对营养物质的新陈代谢亦大有不同。因此，合理的饮食应因人制宜、包含必需和适度两个基准。《素问》：“饮食自倍，肠胃乃伤”，表明进食过饱，也会损伤脾胃功能。《素问》：“肥者令人内热，甘者令人中满”，长期嗜食肥甘，影响脾胃运化功能，日久生理功能失于代偿，就会导致体质发生变化。《素问》：“肝苦急，

急食甘以缓之，心苦缓，急食酸以收之，脾苦湿，急食苦以燥之，肺苦气上逆，急食苦以泄之，肾苦燥，急食辛以润之。”《素问》：“久而增气，物化之常也，气增而久，夭之由也。”《素问》：“是故味过于酸，味过于咸，味过于甘，味过于苦，味过于辛，”《素问》：“气味，辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴。”表明每种饮食都有自身的寒热偏向及所属特性，饮食多元化，可使其偏性相互综合抵消，是总体偏性趋于平衡。当个人体质发生偏颇时，机体会增加对于有相反偏性的食物的需求，以食物的偏性来纠正体质的偏颇，然而若长期偏食某类食物，寒热及五味的作用达到一定程度后，超过机体自身调节均衡能力，就会影响甚至改变脏腑阴阳平衡状态，而形成新的体质，甚至产生疾病。另有研究^[27]提出，长期处于饥饿状态的人，更易形成倦怠质。寒为阴邪，易伤阳气，生冷食物入胃，会直接损伤脾胃之阳气，形成脾虚体质；辛辣炙烤之物性偏燥热，长期进食会使体内阴阳失衡，形成火热之体。郑承铎等^[28]人调查发现，食物的寒热温凉性味偏差会对人体自身阴阳调节产生影响。

2.1.2.2 劳逸运动

《素问》：“久视伤血，久卧伤气，久坐伤肉，久立伤骨，久行伤筋”；适当的休息，可以消除疲劳，恢复体力和脑力，不会使人致病。但长期久坐久卧，四肢关节处于相对静态，也可伤气伤肉，日久局部气血运行不畅，正气不足，而致体质虚弱多病。正常且强度适当、频率适宜的劳动和体育锻炼，有助于气血通达，增强体质，但过度活动，以至于伤筋伤骨，也会影响体质形成^[29]。可见极逸极劳均可影响体质，因此应当劳逸结合、劳逸适度、劳中有逸、逸中有劳。诚如《吕氏春秋》：“流水不腐，户枢不蠹”，即生命在于运动，适当的体育运动对人的体质向着良性方向发展有积极作用，过度运动亦会损伤机体；中医养生中的太极拳、五禽戏等整体动作动静适度，不紧不慢、协调全身、通达内外，是动中有静、静中藏动的养生导引典范^[30]。有研究^[31]证实了大强度运动对实性体质（湿热质），小强度运动对虚性体质（气虚质）的功能、状态具有改善作用。

2.1.2.3 精神情绪

精神舒畅，气机条达，气血运行通畅、脏腑生理功能协调，体质就会更加强

健。《灵枢》：“意志和则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五脏不受邪矣。”如果长期存在精神情绪刺激，或突然遭到强烈的精神创伤，超过机体正常可调节范围，就会影响气血运行和脏腑功能^[32]。《素问》：“怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾；《素问》：“怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结。”人的多种情绪由五脏之气所化，具有五行属性，并与所属脏器相对应。《素问》：“暴乐暴苦，始乐后苦，皆伤精气，精气竭绝，形体毁沮。”骤然的情绪转变或强烈的精神刺激可直接损伤人体精气，甚至动摇原本的稳健体质基础。现代医学证实了机体体质与某些精神疾病的发病密切相关^[33]。冯文林等^[34]人通过对健康人与抑郁症患者体质的对比分析，发现在抑郁症病人中，气虚体质的人数多于健康对照组，差异具有统计学意义。《素问》：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”因此日常生活中应注意发现并及时调节不良情绪，保持恬淡虚无的精神状态，以保全精神^[35]。

2.1.2.4 地理环境因素

《素问》：“天食人以五气，地食人以五味”。从古自今，人类都是从自然界中获取生存物资来维持自身生命活动，自然界也通过源源不断地供给营养物质给人类，来实现对机体的潜移默化的影响。因此长期生活在同一地域环境中的人会在该地域环境的影响下逐渐形成相似的体质趋势及文化风俗差异^[36]。如“千里不同风，百里不同俗”。《素问》中详细描述了古代人因为居处地理环境的不同，形成不同各具特色的饮食习惯，长期的自然环境及饮食习惯导致群体体质的倾向性，产生因体质偏向而好发的疾病^[37]。《医学源流论》：“人禀天地之气以生，西北之人气深而厚，东南之人气浮而薄。”这说明因长期生活在不同的地域自然环境中，形成了不同地区中人群中类似的体质偏性。王琦^[38]等通过对 1036 例痰湿体质调研，发现痰湿体质的发生率与地理区域有非常显著的相关性。

2.1.2.5 年龄差异

年龄是影响体质的重要因素之一。伴随人体生、长、壮、老的变化，身体脏腑功能、气血津液及代谢也会呈现阶段性的改变，体质从稚弱到逐渐盛壮再转而慢慢衰退，各个阶段均有其各自特征^[39]。《黄帝内经》中明确总结了随着年龄的

增长,人体的气血精液、脏腑功能的盛衰规律。如《素问》中记载了关于女子年龄与身体盛衰的规律,指出女子以七为周期,从七岁至二十八岁肾气逐渐充盛,经历齿更发长、天癸至、真牙生、筋骨坚等阶段,最终达到身体盛壮的体质状态;至五七脏腑经脉功能逐渐衰退,气血津液衰少,七七天癸竭形坏无子。《素问》中关于男子精气满溢衰少与年龄的相关规律,其中指出男子以八为周期,自出生始肾气逐渐充盛,长发更齿、天癸至,肌肉丰壮,三十二岁气血体质达到巅峰状态,后精气逐渐衰退,齿槁发堕、天癸竭、脏腑精气衰竭。人体的生长发育过程中,小儿的生理特点为稚阴稚阳、脏腑娇嫩,同时也是在小儿阶段体质的基本特点^[40]。随着年龄的增长,体质逐渐盛壮,至青春期末,体质基本定型;青壮年是人体五脏六腑气血精气的全盛时期,因而也是体质最强健阶段;及至老年,脏腑机能减退,体质日趋下降,百病由生。因此可知老年人容易发病,也是由于老年人的体质特征决定的^[41]。现代研究中,王琦等^[42]人在调查发现:体质在群体中所占比例会随着年龄增长而发生变化;随着年龄增大,平和质越来越少;偏颇质随年龄增高而增多,尤其为气虚质、阳虚质和血瘀质;体质分布比例在不同年龄段也有差异,如在年轻人中,湿热质、气郁质更多;中老年人中多见痰湿质。

2.1.2.6 性别因素

男女因性别不同,其体质亦各有特征。首先在发育阶段基数的差异:在《素问·上古天真论篇》可知女子是以七为阶段基数,男子是以八为阶段基数,女子的发育较男子早 1—2 年左右。其次是因生殖特征精血偏重有差异:《灵枢》篇指出:“妇人之生,有余于气,不足于血。”女子由于有经带胎产的生理特点,体质特征多是气盛血虚,基于此体质特征,后世医家多强调女子以血为本的治疗指导思想^[43]。《女科百问》:“男子以精为本,女子以血为源。”而泄精是男子所独有,男子生理特征,其精气易亏,故体质多为精气虚少。匡调元^[44]提出“男子以肾为先天,女子以肝为先天”之说,可见性别差异,先天脏腑功能偏向亦有不同。

从现代研究来看,男女性别不同,其体质亦各有特征。王莉等^[45]等人在体质调查研究发现:女性失调偏颇体质明显多于男性,女性中体质偏颇以虚弱、精血不足体质多见。由于男女性别因素,在一些疾病发病率中有显著差异,如在血液

病、心血管病中，男性发病率要高于女性 31.2% -50.2%。

2.2 体质的分类

2.2.1 内经体质分类

五行分类法：《灵枢》中，将人体外在特点按五行学说，划分为五种不同的体质类型。此五种类型作为基本型，再将每一类基本型推演成五种亚型，共为二十五种体质类型。由于此种分类方法包括了个体形态、心理特征、性格特点诸多方面，是《内经》中最为全面的体质分类方法^[46]。

阴阳分类法：此种分类法将体质按阴阳来划分，具体分为太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳和平五类体质。

体型分类法：《灵枢》中将体质按外表体型肥瘦、壮弱不同分为五种类型，分别为：肥人、瘦人、常人、壮士真骨、婴儿，指出了各自外形特点、气血盛衰情况及各自的针刺治疗原则。

2.2.2 现代医学体质分类

现代体质的分类方法，虽大多以气血津液理论为基础，但因不同分类者对体质的认知及划分角度的差异，使得体质分类方法也各不相同^[47]。①1978 年匡调元^[48]将体质划分为正常质、晦涩质、腻滞质、燥红质、迟冷质、倦白光质六类。②2005 年王琦^[49]等人经过研究，对原有分类法进行了增补，将中医体质分为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、瘀血质、气郁质、特禀质九种基本类型。2009 年此九种体质分类方法成为我国现行的中医体质分类标准，经验证有良好的适应性、可行性。

三、关于本次研究结果的讨论

1.研究对象客观资料的一般特征

本次研究对从临床收集的 328 例原发性高脂血症患者,在性别、年龄、BMI、血脂指标、吸烟史、饮酒史、运动锻炼、饮食偏好等方面进行统计分析。得出以下结论:

从性别与年龄差异:男性 181 例、占总例数 55.2%,女性 147 例、占总例数 44.8%,男性多于女性。男性平均年龄为 41.2 岁,女性平均年龄为 54.8 岁;可见男性发病年龄早于女性。年龄分组中中年组患病人数为 213 例(64.9%),明显高于青年组 74 例(22.6%)与老年组 41 例(12.5%)。《黄帝内经·阴阳应象大论》中:“年四十而阴气自半也,起居衰矣。”从“年四十”开始,人体开始进入衰退阶段,人体正气开始衰弱减少,由数据统计结果也可见中年阶段原发性高脂血症患者数量明显增加。此外拓其原因,也可能与中年患者多为家庭支柱,受工作、生活及精神等情志因素影响,导致肝失疏泄,痰涎水湿代谢失常,故易形成痰浊瘀血等而形成本病。

本次研究将 BMI 分组中,328 例患者 BMI 过轻组仅 3 例(0.9%),正常组 134 例(40.9%),过重组及以上共 191 例(58.2%),故可认为原发性高脂血症患者大多数体重过重。①从性别与 BMI 分布差异来看:男性超过正常体重(过重组+肥胖组)占男性总数的 68%;女性超过正常体重(过重组+肥胖)占女性总人数的 46%;表明原发性高脂血症患者中男性体重超重较女性常见。②从年龄分段与 BMI 分布差异来看:青年、中年均为过重组人数最多,分别为 31 例(9.5%)、95 例(29.0%)。汪凯悦^[50]等人亦有研究发现,中年男性的肥胖率高于同年龄段女性;在中年阶段,男性的超重率高于同年龄段女性的超重率性($P<0.05$),考虑可能与中年男性社会压力较大有关。。

本次研究患者原发性高脂血症临床分类中,最多为高甘油三酯血症 156 例(47.6%),其次为混合型高脂血症 102 例(31.1%)。在影响因素分布的分析中喜食肥甘 167 例(50.9%),表明半数以上本病患者因饮食偏好而致病。本次研究中血脂指标选用临床血脂检查中 TC、TG、HDL-C 及 LDL-C 四项。①在性别比较中,男性的 TG 均值明显高于女性,推测与大多男性的吸烟饮酒不良生活习惯、饮食结构有关。②从年龄分组的差异来看,随着年龄的增长,TC 均值也逐渐升高,而具有抗动脉粥样硬化作用的 HDL-C 随着年龄的增长出现先升高后降低的趋势。③在 BMI 分组比较结果中,TG、HDL-C 在不同的 BMI 分组具

有明显的差异性：过重组、肥胖组 TG 均值高于正常组，而 HDL-C 均值低于正常组。

2.研究对象的中医证候分布情况

本次研究对研究对象中医证型在性别、年龄、BMI、血脂异常分类上进行了统计分析。得出以下结论：

在本次 328 例病例中：痰湿阻遏证最多为 114 例（34.8%）>气滞血瘀证 68 例（20.7%）>肝肾阴虚证 63（19.2%）>脾肾阳虚证 43（13.1%）>阴虚阳亢证 40（12.2%）。

从性别在证型分布上的差异来看，在气滞血瘀证中，男性 32 例（9.76%）、女性 36 例（10.96%），女性辩证为气滞血瘀证较男性多，经卡方检验，差异有统计学意义。如有医家言：女子以肝为先天，以血为用，肝气为人体气机运行之总领，若肝郁气滞，则易导致气不行血，气血瘀滞而发病。从年龄分组看，青年组、中年组均为痰湿阻遏证占比最多，分别为 27 例（8.3%）、77 例（23.5%）；老年组中脾肾阳虚证、痰湿阻遏证、气滞血瘀证占比相同。可能与中青年饮食喜好与老年不同有关，中青年饮食偏好辛辣肥腻厚味，日久影响脾胃正常运化功能，痰饮湿浊滞留脉络，引发本病。从 BMI 分组在证型分布不同来看，过轻组共 3 例，分布于肝肾阴虚证与阴虚阳亢证中；正常组在肝肾阴虚证中最多为 39 例（11.9%），过重组、肥胖组均在痰湿阻遏证中人数最多，分别为 62 例（18.9%）、20 例（6.1%）。有医者云：肥人多痰湿。饮食水谷入于胃，经脾胃腐熟功能化为精微物质，运行于脉道中，在脾气散精作用下分散至全身濡养机体内外，若脾虚精微物质不能到达四肢百骸，滞于局部则成痰成湿成瘀，而形成本病。

3.研究对象的中医体质分布情况

在 328 例研究对象中，中医体质类型分型及数量占比分别为：平和质 67 例（20.4%）、气虚质 23 例（7.0%）、阳虚质 19 例（5.8%）、阴虚质 11 例（3.4%）、湿热质 81 例（24.7%）、痰湿质 90 例（27.4%）、血瘀质 21 例（6.4%）、气郁质 13 例（4.0%）、特禀质 3 例（0.9%）。综合来看，平和质 67 例（20.4%）、

偏颇体质 261 例（79.6%），可知原发性高脂血症患者中绝大多数为偏颇体质。从数据结果来看，痰湿质 90 例（27.4%）、湿热质 81 例（24.7%）、气虚质 23 例（7.0%）位于偏颇体质前三；其病机可能与地域、饮食两方面有关：其一成都市位于四川盆地、气候潮湿，湿属阴邪，最易损伤阳气，又因同气相求，湿邪侵袭人体，必先困于脾，使脾阳不振，运化失权，水湿停聚，日久酿生痰湿，滞于血脉，形成本病。其二饮食上嗜食辛辣厚味，日久导致湿热蕴结中焦，中焦气机不畅、肝失疏泄，胆汁分泌失常、水谷精微运化失度，湿浊痰瘀蕴结于脉络中，日久导致血脂异常的发生。

从性别差异的体质分布来看：男性、女性例数占比前两位均为痰湿质、湿热质。男性痰湿质 55 例（16.8%），湿热质 49 例（14.9%）；女性痰湿质 35 例（10.6%），湿热质 32 例（9.8%）。在气虚质与阳虚质中，女性明显多于男性， $P<0.05$ 。故在治疗高脂血症上，应注意男女两性体质特点上的差异，男子多宜清化，女子多宜温化。

从年龄差异来看：在个体发育过程中，体质的发展也要经历几个阶段：从幼年到青年、从青年到壮年再至老年，人体气血阴阳也要经历从稚阴稚阳到阴阳充盛再到衰弱的过程。本次研究也发现体质在各年龄分布存在差异：在青年组中湿热质最多，中年组前三位分别为痰湿质、湿热质、平和质；老年组痰湿质多见。青年时期，气血充盛、机体阳气充足，致病后易从热化，且年轻人在饮食上更倾向于辛辣刺激食物，日久酿生湿热。中年时期，虽然机体在生理上由盛转衰，若脾胃健运失常、水谷精微失于运化，故易生痰生湿；但阴阳依然充盛，故平和质亦多见。老年时期，脏腑功能虚衰，因虚致实，导致肝失疏泄、脾失健运、肾失气化，三焦水道不利，水液代谢失调，痰浊居于血脉，血流动力学改变^[51]，形成本病。因此，对不同年龄段高脂血症患者进行干预治疗时，青年人从饮食运动上调节；中年人虽脏腑机能逐渐由盛转衰，但总归正气尚可，因此在治疗时应以祛实为主；老年人体质虚实夹杂，多采用虚实同治、以补虚为主的治法。

从体重指数 BMI 的差异来看：过轻组 3 例，分别为阴虚质 2 例、特禀质 1 例；正常组中平和质最多；偏重组及肥胖组前三位均为：痰湿质、湿热质、平和质；非常肥胖组分布于痰湿质与湿热质中。由上述可见：原发性高脂血症中 BMI 体重过重（包括偏重组+肥胖组）患者的体质分布主要集中在痰湿质和湿热质，

表明体重指数与痰湿质、湿热质密切相关，如有医家总结“肥人多痰湿”。

为分析各中医体质与客观指标的相关性，采用多元多因素 logistic 回归，回归分析结果表明：女性与气虚质、阳虚质相关，相比阳虚质，原发性高脂血症患者中气虚质女性更多。BMI 与阴虚质、湿热质、痰湿质高度相关；阴虚质与 BMI 呈负相关，如有医家言：瘦人多虚火；湿热质、痰湿质与 BMI 呈正相关。TG 与痰湿质、湿热质密切相关，痰湿质、湿热质患者 TG 值较一般患者高。

四、研究结论

（1）原发性高脂血症中，患者年龄主要集中在 41-65 岁，男性数量多于女性，患者体重大多数超过正常体重上限。在原发性高脂血症的血脂指标中，患者的体重指数与 HDL-C 呈负相关。

（2）原发性高脂血症患者中医证型分布有差异，其中女性气滞血瘀证较男性多，青年、中年患者痰湿阻遏证多见。痰湿阻遏证的患者更容易体重过重及肥胖。

（3）原发性高脂血症患者中气虚质、阳虚质多为女性患者，其中气虚质与女性的相关性更高。BMI 与阴虚质、湿热质、痰湿质高度相关；阴虚质与 BMI 呈负相关，湿热质、痰湿质与 BMI 呈正相关。痰湿质、湿热质患者的 BMI、TG 数值较其他体质患者更高。

不足与展望

因个人能力有限，本研究样本量偏小，可能影响结果的客观性，也不能普遍用来说明原发性高脂血症与证型、中医体质的相关性；

在此次研究中，对于兼夹体质的患者选择以评分高的体质为主，证型判定中无明显症状的患者以舌苔脉象等判定证型，可能对调查结果造成了一定的影响。未设置与健康人群中医体质的对比研究。

本次研究采用的问卷调查表，多靠患者的主观感受和记忆来填写，对调查结果造成了一定的偏倚。

在今后的研究中，应增加样本量，设立对照组，注重调查表的设计，获取更客观的资料，得到更准确的研究结果。

致谢

值此论文圆满完结之际，也正是预示着我的硕士研究生学习生活即将结束。在这期间，虽遇到过困难，但也得到了更多帮助。在此，首先要向导师冷建春教授表示由衷的感谢，感谢您三年来的悉心训导与帮助。您严谨的治学态度，孜孜不倦的工作精神一直激励着我，感谢您的辛勤培育。

感谢全科所有老师们对我学业上的指导、生活上的关心。

感谢各位科室同门、室友及所有朋友们，三年时光能有你们一路同行，是我之幸。

感谢家人对我的支持及无私奉献。

最后，向所有参加评阅论文和毕业答辩的指导专家、老师们表示最衷心的感谢！

参考文献

- [1]国家计划和卫生委员会疾病预防控制局.中国居民营养与慢性病状况报告.(2015 年).北京:人民卫生出版社,2015
- [2]Moran A, Gu D,Zhao D,et al.Future cardiovascular disease in china: markov model and risk factor scenario projections from the coronary heart disease policy model-china.Circ Cardiovasc Qual Outcomes,2010,3:243-252.
- [3]李剑虹,王丽敏,米生权,等.2010 年我国成年人血脂异常知晓率和治疗率及控制率调查.中华预防医学杂志,2012,46:687-691.
- [4]诸骏仁,高润霖,赵水平,陆国平,赵冬,李建军.中国成人血脂异常防治指南(2016 年修订版)[J].中国循环杂志,2016,31(10):937-953.
- [5]GB/T 16751.2-1997, 中医临床诊疗术语 证候部分[S].
- [6]中医体质分类与判定[J].中华养生保健,2009(09):38-39.
- [7]中国肥胖问题工作组. 中国成人超重和肥胖症预防与控制指南(节录)[J]. 营养学报,2004(01):1-4.
- [8]贾萌,杨惠民.肥胖与非肥胖高脂血症病人中医证型特点分析[J].中西医结合心脑血管病杂志,2019,17(21):3285-3287.
- [9]王小刚,赵娴,李悦,屈艳伟,张娇娇,王梦静,武珊.高脂血症发病机制及治疗研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2020,22(12):196-200.
- [10]季顺欣. 血脂异常的中医病因病机研究 [J] . 中医临床研究, 2021, 4 (14) : 53-54.
- [11]清·张志聪. 黄帝内经灵枢集注.北京: 中医古籍出版社, 2012.
- [12]王米渠. 论从“肾为先天之本”到“中医遗传学” [J] . 中国中医基础医学杂志. 1996, 2 (4) : 6-9.
- [13]葛怡兰,刘佳敏,高岩,张丽华,李艳,乌汉,蒋立新.中国家族性高胆固醇血症诊疗现状[J].中国动脉硬化杂志,2018,26(08):851-857.
- [14]杨兰.高脂血症与肝相关性的中医理论探讨[J].辽宁中医学院学报,2005(04):322-323.
- [15]王安璐,徐浩.徐浩教授辨体质从肝、脾、肾治疗高脂血症经验[J].中华中医药杂志,2015,30(06):1999-2001.

- [16] 杨兰. 高脂血症与肝相关性的中医理论探讨[J]. 辽宁中医学院学报, 2005(04):322-323.
- [17] 郭姣, 朴胜华. 从高脂血症发病低龄化趋势探讨其中医发病机制[J]. 中医药信息, 2008(06):4-6.
- [18] 王安璐, 徐浩. 徐浩教授辨体质从肝、脾、肾治疗高脂血症经验[J]. 中华中医药杂志, 2015, 30(06):1999-2001.
- [19] 李艳, 孙珂焕, 白芳, 罗焕敏, 吴正治. 高脂血症相关疾病发病机制研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2019, 21(04):84-87.
- [20] 马壮. 《黄帝内经》体质分类的理论与应用[D]. 辽宁中医药大学, 2008.
- [21] 王琦. 中医体质学[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [22] 王琦. 中医体质学[M]. 北京: 中国医药科技出版社出版, 1995. 70~71.
- [23] 王琦. 9种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据[A]. 中华中医药学会 (China Association of Chinese Medicine). 中医药优秀论文选(上)[C]. : 中华中医药学会, 2009:11.
- [24] 吴满武, 蒋叶均, 杜和春, 傅奇琴. FTO 基因多态性对低出生体重及肥胖的影响[J]. 中国妇幼健康研究, 2019, 30(02):148-153.
- [25] 焦会永, 赵雯婷, 李彩霞, 黄艳梅, 叶健. 健康成年人身高全基因组关联及遗传性缺失研究进展[J]. 中国法医学杂志, 2017, 32(01):36-39.
- [26] 高利英. 运动疗法与饮食控制对高血压、高血脂的防治作用[J]. 临床医药文献电子杂志, 2019, 6(58):54-55.
- [27] 李秀琴, 吴成斌. 饮食疗法在气虚体质者中的应用[J]. 甘肃科技, 2020, 36(22):151-153.
- [28] 郑承铎, 郑立升, 杨晓云等. 福州人饮食性味和温度高低与体质关系研究[J]. 中国中医基础医学杂志 2002 8 (2) : 58.
- [29] 曾洁, 谢洁妍, 严学勤. 运动处方对学龄前儿童体质健康的影响[J]. 中国当代医药, 2020, 27(36):102-105.
- [30] 胡益娟, 钟冬灵, 杨璐萍, 陈强, 张福蓉, 金荣疆. 太极拳运动对改善老年人虚弱体质的机制及研究进展[J]. 中国社会医学杂志, 2019, 36(03):285-288.
- [31] 何栩, 虞亚明, 崔迪等. 羽毛球和太极拳运动对湿热型和阳虚型体质大学生身体

- 机能的影响[J].河南医学研究,2021,30(03):388-392.
- [32]郝俏也,姜华,郭小龙等.中医体质学说与心身疾病[J].中国卫生产业,2016,13(03):196-198.
- [33]梅燕,黄彦,郑丽,官燮.心理亚健康人群的中医体质辨识及情绪特征[J].重庆医学,2018,47(10):1363-1365.
- [34]冯文林 梅晓云. 抑郁症发病与体质关系的调查 [J] . 青岛大学医学院学报 2008 44 (3) : 270-272.
- [35]焦丽璞.《黄帝内经》情志致病因素及调摄方法研究[D].山西中医药大学,2020.
- [36]朱华贺,薛征.不同地域反复呼吸道感染患儿中医体质特点[J].河南中医,2019,39(02):220-223.
- [37]蔡睿,中国国民体质地域分布特征的研究.北京市,国家体育总局体育科学研究所,2007-06-01.
- [38]王琦.9 种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据[J].北京中医药大学学报,2005(04):1-8.
- [39]高慧,许朝霞,王庆盛,冯晓,王忆勤.概述不同年龄阶段人群的中医体质及证候特征研究进展[J/OL].世界科学技术-中医药现代化:1-5[2021-04-01].
- [40]张显,刘芳.六经体质理论在儿科的应用探讨[J].中国民间疗法,2021,29(03):11-13+101.
- [41]刘国兴,梁少芬,陆敏红.老年人中医体质辨识研究[J].河南中医,2020,40(09):1399-1402.
- [42]王琦 朱燕波.中国一般人群中中医体质流行病学调查—基于全国 9 省市 21948 例流行病学调查数据 [J] . 中华中医药杂志 2009 24 (1) : 7-12.
- [43]吴惠雯,杨正宁,林思行,宋丽珍,杨朝阳.福州地区健康人群男女体质差异比较分析[J].中国医药科学,2019,9(14):7-9+18.
- [44]匡调元. 体质病理学研究[J] . 成都中医学院学报,1978 ,1 (2) :3~17.
- [45]王莉,何裕民.男女体质特点及其异同的研究——附 2967 例流调资料的模糊识别分析[J].中国中医基础医学杂志,1998(02):8-10.
- [46]周妍妍,康倩倩,于淼,狄舒男,王涛,桑希生.《黄帝内经》体质分类解析[J].中国中医基础医学杂志,2020,26(07):866-868.

- [47]张彩.中医体质辨识现代研究进展[J].中国中医药信息杂志,2020,27(09):141-144.
- [48]匡调元.性别体质学探讨[J].上海中医药杂志,1990(01):1-3.
- [49]王琦.9种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据[J].北京中医药大学学报,2005(04):1-8.
- [50]汪凯悦,徐淑静,时立新,张巧,彭年春.贵阳市某城区中老年人群超重和肥胖流行病学调查[J].贵州医科大学学报,2018,43(07):790-793.
- [51]吴峻.高脂血症与内皮功能障碍相关性研究及贝特类干预治疗机制探讨[D].中南大学,2003.

文献综述

体质与疾病的关系

摘要：体质理论学说是传统中医理论的重要组成部分。中医认为人体体质与先天禀赋、后天饮食、年龄性别、劳逸情志等多种因素相关。体质对疾病的发生、转归、预后起着举足轻重的作用。因此掌握个人体质特征甚至改变个人体质对于预防治疗疾病有着重要的意义^[1]。

关键词：中医；体质；疾病

1. 体质与病因

体质决定了机体对某种致病因素的易感性^[2]。即中医“同气相求”之说。《灵枢·五变》：“一时遇风，同时得病，其病各异”由于脏腑组织的盛衰强弱差异，体质不同，发病情况各异。因此体质的偏向是造成机体易于感受某类疾病的根本原因^[3]。

2. 体质与发病

《灵枢》：“风雨寒热不得虚，邪不能独伤人。”《素问》：“正气存内，邪不可干。”内经中认为，正气虚产生疾病的内在根据，邪气是发生疾病的必要条件^[4]。体质的强弱决定着机体正气的盛衰。因此体质与发病与否有着重要关系^[5]。在某些特殊情况下，邪气主导着是否发病，如若疫戾之气，即使体质盛壮，也应避其毒气以保全性命^[6]。一方面体质的强弱决定机体是否会感受邪气。另一方面人体受邪后，由于体质的不同，发病部位、发病情况也有所差异^[7]。《灵枢》：“在肠胃之时，多寒则肠鸣、飧泄、食不化；多热则溏出糜。”表明发病后的症状是肠鸣飧泄还是溏出糜，取决于机体多寒或是多热的体质偏向，若为阴盛体质病易寒化，则见中焦虚寒之肠鸣飧泄，若为素体阳盛，受邪后从热而化，易出现湿热下注大肠之证^[8]。《素问》中：“其寒者，与病相益，故寒也。其热者，病气胜，阳遭阴，故为痹热。”阳少阴多，感邪后病从寒化，表现为寒痹；阳多阴少，感邪后病从热化，则为热痹。因此在疾病发生发展的过程中，体质不仅是决定机体发病与否的重要根据，还影响着病机的转化与演变^[9]。

3. 体质与疾病预后

《素问》：“精者三日，中年者五日，不精者七日”，意为体质强盛之人感邪之后、三日可愈，体质稍差之人五日可愈，体质较差之人七日可愈。表明体质

不同,驱邪外出之力各有差异。此种记载为应用中医药增强体质正气来预防疾病提供了理论依据^[10]。充分认识掌握机体体质与疾病发生、转化、预后之间的关系,对于临床诊疗具有指导意义^[11]。

4.高脂血症与中医体质相关研究

中医药在治疗高脂血症方面较西医有很大优势。《素问·四气调神大论》:“是故圣人不治已病,治未病;不治已乱,治未乱。”因此明晰机体的体质偏颇及其易感疾病,纠正体质偏颇、排除易感因素,才能防范于未然,即中医“治未病”思想。近年来高脂血症与体质的相关性研究越来越多。高脂血症的发病与体质呈相关性。王迎^[12]通过研究发现,高脂血症患者大多有肥胖、胸闷、痰多等症状,体质类型在年龄分布也有差异,老年高脂血症者中痰湿质最多,其次为气虚质。陶亮等^[13]人研究表明,阳虚质、气虚质在血脂异常患者占比较高。张婷婷^[14]亦认为气虚质和阳虚质形成高脂血症危险因素,在不同性别中,高脂血症的易患病体质也有差异。黄芸^[15]的研究结果显示痰湿质是导致原发性高脂血症发生的重要因素。耿彦婷^[16]通过健康人与患者的血脂指标对比实验发现,湿热质、痰湿质、阳虚质比其他体质更易患病。谭亚男^[17]通过分析原发性高脂血症体质类型与客观指标的相关性得出,原发性高脂血症易感体质前三位分别为阳虚质、湿热质、气虚质。段利敏^[18]研究患者心肺耐力与体质的相关性,发现中年高脂血症中占比例最多的体质为阳虚质。赵宇捷^[19]发现,在高脂血症并发症患者与亚临床表现患者的体质分布存在差异,对于中老年原发性高脂血症患者来说,气虚质与血瘀质是其并发冠心病、脑梗死的危险因素。越来越多的研究表明,血脂指标与体质之间有一定的相关性。韩丽蓓^[20]通过对糖尿病合并高脂血症患者进行体质和血脂指标相关性的研究,发现以平和质为对照,湿热质组TC、LDL-C均值最高。王迎^[12]发现在老年高脂血症患者中,平和质的TC最低,血瘀质的TC升高最明显。张妍^[21]在对原发性血脂异常与中医体质分析中发现,TC值越高、越不容易形成气虚质,形成湿热质的可能更大;TG值痰湿质和湿热质呈正相关;HDL-C与阳虚质、湿热质成正相关;LDL-C的升高,越不容易形成阳虚质和阴虚质。

参考文献

- [1]王莉. 男女体质特点及其异同的研究[J]. 中国中医基础医学杂志 1998 4 (2): 7-9.
- [2]孙广仁.中医基础理论[M].北京: 中国中医药出版社 , 2007:203.
- [3]匡调元.性别体质学探讨[J].上海中医药杂志,1990(01):1-3.
- [4]姚晓天 程志清. 中医体质学说的流行病学研究进展[J]. 浙江中西医结合杂志 2004 14(6): 395.
- [5]丁萌. 体育运动对体质调整作用的中医学探讨[J]. 体育科学 2008 28(11): 82-86.
- [6]郝燕. 慢性疲劳综合征及其影响因素与中医体质的相关性及其临床研究[D].广州: 广州中医药大学, 2013.
- [7]匡调元.体质病理学研究[J]. 成都中医学院学报,1978 ,1 (2) :3~17.
- [8]郝俏也,姜华,郭小龙等.中医体质学说与心身疾病[J].中国卫生产业,2016, 13(03):196-198.
- [9]张惠敏 郑守曾. 气虚体质的研究进展[J]. 北京中医药大学学报 2004 27 (1): 14-16.
- [10]赵民望.体质与疾病和康复[J].光明中医. 1999,14(4):5~8.
- [11]骆斌,王琦.痰湿体质论析[J].安徽中医学院学报.1999,18(5):10~11.
- [12]王迎. 老年高脂血症中医体质分型与血脂指标的相关性研究[D].南京中医药大学,2012.
- [13]陶亮,赫忠朴,陈民.血脂异常与中医体质关系的研究[J].辽宁中医杂志,2012,39(02):258-260.
- [14]张婷婷. 原发性高脂血症患者体质、证素特点及其相关因素研究[D].福建中医药大学,2013.
- [15]黄芸.长风社区老年高脂血症患者与其中医体质的相关性分析[J].上海医药,2015,36(02):27-29.
- [16]耿彦婷,王欢,胡元会,杨正,杜柏.健康人不同中医体质者血清血脂水平的比较研究[J].中西医结合心脑血管病杂志,2015,13(14):1585-1588.
- [17]谭亚男. 原发性高脂血症中医体质类型与客观指标相关性研究[D].大连医科

大学,2017.

[18]段利敏. 中年高脂血症患者心肺耐力与中医体质分型研究[D].福建中医药大学,2017.

[19]赵宇捷. 中老年人原发性血脂异常与中医体质的相关性研究[D].北京中医药大学,2011.

[20]韩丽蓓,崔红霞,刘金凤,李小玲,王丽娟.2型糖尿病合并高脂血症患者中医体质类型及与血脂指标的相关性研究[J].北京中医药大学学报(中医临床版),2011,18(03):4-7.

[21]张妍. 原发性血脂异常症患者体质类型与血脂分型的相关性研究[D].北京中医药大学,2011.

附录

附录1 一般情况调查表

姓名		性别		年龄	岁	
身高	m	体重	Kg	BMI	Kg/m ²	
吸烟史	年	饮酒史		过敏史		
既往病史						
饮食偏好						
体育锻炼						
TC:	mmol/L	TG:	mmol/L	HDL-C:	mmol/L	
LDL-C:	mmol/L					
脾肾阳虚:	面色㿔白 ☐	形体肥胖 ☐	下肢浮肿 ☐	性欲减退 ☐	气短乏力 ☐	神疲懒言 ☐
	自汗 ☐	畏寒肢冷 ☐	夜尿频数而清 ☐	精神疲倦 ☐	嗜睡 ☐	舌象 脉象
肝肾阴虚:	两目干涩 ☐	视力减退 ☐	耳鸣耳聋 ☐	失眠多梦 ☐	五心烦热 ☐	腰膝酸软 ☐
	健忘 ☐	齿松发脱 ☐	午后颧红 ☐	潮热盗汗 ☐	男子遗精或早泄 ☐	舌象 脉象
痰浊阻遏:	头重头蒙 ☐	口中臭秽 ☐	脘腹胀满 ☐	妇女带下量多 ☐	身体困重 ☐	身热不扬 ☐
	口中粘腻 ☐					舌象 脉象

阴虚火旺：	头痛 ☐	头晕面赤 ☐	烦躁易怒 ☐	口干 ☐	五心烦热 ☐	大便干结 ☐
						舌象 脉象
气滞血瘀：	口渴不欲多 饮 ☐	口唇、面色 紫暗 ☐	胸痛、胸闷 ☐	胁下痞块 ☐	胸闷胀满 ☐	胸闷刺痛 ☐
	肢体麻木 ☐					舌象 脉象
中医证型						

附录2 中医体质量表

1.阳虚质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您手脚发凉吗?	1	2	3	4	5
(2) 您胃腕部、背部或腰膝部怕冷吗?	1	2	3	4	5
(3) 您感到怕冷、衣服比别人穿得多吗?	1	2	3	4	5
(4) 您比一般人不了寒冷 (冬天的寒冷，夏天的冷空调、电扇等。	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5

(6) 您吃(喝)凉的东西 会感到不舒服或者怕吃 (喝)凉东西吗?	1	2	3	4	5
(7) 你受凉或吃(喝)凉 的东西后, 容易腹泻(拉 肚子)吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

2. 阴虚质

请根据近一年的体验 和感觉, 回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到手脚心发热 吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感觉身体、脸上发 热吗?	1	2	3	4	5
(3) 您皮肤或口唇干吗?	1	2	3	4	5
(4) 您口唇的颜色比一般 人红吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易便秘或大 便干燥吗?	1	2	3	4	5
(6) 您面部两潮红或 偏红吗?	1	2	3	4	5
(7) 您感到眼睛干涩 吗?	1	2	3	4	5
(8) 您活动量稍大就	1	2	3	4	5

容易出虚汗吗?					
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

3.气虚质

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 你容易疲乏吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易气短(呼吸短促, 接不上气吗?)	1	2	3	4	5
(3) 您容易心慌吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易头晕或站起时晕眩吗?	1	2	3	4	5
(5) 您比别人容易患感冒吗?	1	2	3	4	5
(6) 您喜欢安静、懒得说话吗?	1	2	3	4	5
(7) 您说话声音无力吗?	1	2	3	4	5
(8) 您活动量就容易出虚汗吗?					
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

4.湿热质

请根据近一年的体验和感	没有	很少	有时	经常	总是
-------------	----	----	----	----	----

觉，回答以下问题	(根本不)	(有一点)	(有些)	(相当)	(非常)
(1) 您的皮肤在不知不觉中会出现青紫瘀斑(皮下出血)吗?	1	2	3	4	5
(2) 您两颧部有细微红丝吗?	1	2	3	4	5
(3) 您身体上有哪里疼痛吗?	1	2	3	4	5
(4) 您面色晦黯或容易出现褐斑吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易有黑眼圈吗?	1	2	3	4	5
(6) 您容易忘事(健忘)吗?	1	2	3	4	5
(7) 您口唇颜色偏黯吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

5.痰湿质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到胸闷或腹部胀满吗?	1	2	3	4	5
(2) 您感到身体重滞不轻松或不爽快吗?	1	2	3	4	5
(3) 您腹部肥满松软吗?	1	2	3	4	5

(4) 您有额部油脂分泌多的现象吗?	1	2	3	4	5
(5) 您上眼睑比别人肿(仍轻微隆起的现象)吗?	1	2	3	4	5
(6) 您嘴里有黏黏的感觉吗?	1	2	3	4	5
(7) 您平时痰多,特别是咽喉部总感到有痰堵着吗?	1	2	3	4	5
(8) 您舌苔厚腻或有舌苔厚厚的感觉吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

6. 血瘀质

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您的皮肤在不知不觉中会出现青紫瘀斑(皮下出血)吗?	1	2	3	4	5
(2) 您两颧部有细微红丝吗?	1	2	3	4	5
(3) 您身体上有哪些疼痛吗?	1	2	3	4	5

(4) 您面色晦黯或容易出现褐斑吗?	1	2	3	4	5
(5) 您容易有黑眼圈吗?	1	2	3	4	5
(6) 您容易忘事(健忘)吗	1	2	3	4	5
(7) 您口唇颜色偏黯吗?	1	2	3	4	5
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

7. 特禀质

请根据近一年的体验和感觉, 回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您没有感冒时也会打喷嚏吗?	1	2	3	4	5
(2) 您没有感冒时也会鼻塞、流鼻涕吗?	1	2	3	4	5
(3) 您有因季节变化、温度变化或异味等原因而咳嗽的现象吗?	1	2	3	4	5
(4) 您容易过敏(对药物、食物、气味、花粉或在季节交替、气候变化时)吗?	1	2	3	4	5
(5) 您的皮肤容易起荨麻疹(风团、风疹块、风疙瘩)吗?	1	2	3	4	5

(6) 您的因过敏出现过紫癜（紫红色瘀点、瘀斑）吗？	1	2	3	4	5
(7) 您的皮肤一抓就红，并出现抓痕吗？	1	2	3	4	5
判断结果： ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

8. 气郁质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您感到闷闷不乐吗？	1	2	3	4	5
(2) 您容易精神紧张、焦虑不安吗？	1	2	3	4	5
(3) 您多愁善感、感情脆弱吗？	1	2	3	4	5
(4) 您容易感到害怕或受到惊吓吗？	1	2	3	4	5
(5) 您胁肋部或乳房腹痛吗？	1	2	3	4	5
(6) 您无缘无故叹气吗？	1	2	3	4	5
(7) 您咽喉部有异物感，且吐之不出、咽之不下吗？	1	2	3	4	5
判断结果： ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

9.平和质

请根据近一年的体验和感觉，回答以下问题	没有 (根本不)	很少 (有一点)	有时 (有些)	经常 (相当)	总是 (非常)
(1) 您精力充沛吗?	1	2	3	4	5
(2) 您容易疲乏吗? *	1	2	3	4	5
(3) 您说话声音无力吗? *	1	2	3	4	5
(4) 您感到闷闷不乐吗? *	1	2	3	4	5
(5) 您比一般人耐受不了寒冷(冬天的寒冷,夏天的冷空调、电扇)吗? *	1	2	3	4	5
(6) 您能适应外界自然和社会环境的变化吗?	1	2	3	4	5
(7) 您容易失眠吗? *	1	2	3	4	5
(8) 您容易忘事(健忘)吗? *					
判断结果: ☐ 是 ☐ 倾向是 ☐ 否					

(注: 标有*的条目需先逆向计分, 即: 1→5, 2→4, 3→3, 4→2, 5→1, 再用公式转化分。

附录3 在读期间公开发表的学术论文、专著及科研成果

序号	成果（论文、专著、获奖项目）名称	成果鉴定、颁奖部门及奖励类别、等级或发表刊物与出版单位、时间	本人署名次序
1	《藿朴夏苓汤加减治疗验案 5 例》	世界最新医学信息文摘，2021 年 17 期	1

